Optimal Untuk Negeri

Optimal

Buku Ajar
PEMERIKSAAN ANTENATAL TERPADU
Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, dan Interpretasi Temuan

Ika Nur Saputri • Feby Purnamasari • Frani Mariana Sunaeni • Ekki Noviana

Editor: Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.



BUKU AJAR
PEMERIKSAAN ANTENATAL TERPADU: ANAMNESIS, PEMERIKSAAN FISIK, DAN INTERPRETASI TEMUAN

Penulis:
Dr. Bd. Ika Nur Saputri, SST., M.Keb.
Feby Purnamasari, S.ST., Bdn., M.Keb.
Frani Mariana, SST., M.Keb.
Sunaeni, S.ST., M.Keb.
Ekki Noviana, M.Tr.Keb., Bd.

Editor:
Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.

Optimal Untuk Negeri

Buku Ajar Pemeriksaan Antenatal Terpadu:
Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, dan Interpretasi Temuan

Penulis:
Dr. Bd. Ika Nur Saputri, SST., M.Keb.
Feby Purnamasari, S.ST., Bdn., M.Keb.
Frani Mariana, SST., M.Keb.
Sunaeni, S.ST., M.Keb.
Ekki Noviana, M.Tr.Keb., Bd.

Editor: Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7756-83-1

Cetakan Pertama: Agustus, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Buku Ajar Pemeriksaan Antenatal Terpadu: Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, dan Interpretasi Temuan dapat disusun sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan dalam memahami pemeriksaan antenatal secara sistematis, terarah, dan sesuai standar pelayanan ANC. Buku ini hadir untuk mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa dalam melakukan pengkajian ibu hamil, menyiapkan pemeriksaan, menjaga privasi dan keselamatan pasien, serta menginterpretasikan temuan klinis sebagai dasar pengambilan keputusan asuhan kebidanan.

Materi dalam buku ini disusun secara bertahap, dimulai dari konsep dasar pemeriksaan antenatal terpadu, tujuan pemeriksaan, sasaran dan indikator pelayanan antenatal care, serta standar pelayanan ANC yang meliputi jadwal, komponen minimal, dan indikator mutu. Pembahasan dilanjutkan dengan persiapan pemeriksaan ANC, meliputi alat, lingkungan, privasi, dan pencegahan infeksi, kemudian pemeriksaan fisik umum pada kepala-leher, jantung-paru, abdomen non-obstetri, dan ekstremitas. Selain itu, buku ini juga membahas pemeriksaan abdomen obstetri melalui palpasi Leopold, pengukuran tinggi fundus uteri, penilaian presentasi janin, penurunan bagian terendah, serta penilaian kesejahteraan janin melalui DJJ, gerak janin, dan pemantauan pertumbuhan.

Penulis berharap buku ajar ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi kebidanan dalam memperkuat keterampilan pemeriksaan antenatal terpadu serta kemampuan mengenali temuan normal maupun tanda bahaya pada kehamilan. Setiap bab dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran Knows How, portofolio, DOPS, tabel red flags dan eskalasi, rangkuman materi, serta daftar pustaka untuk mendukung pembelajaran yang aktif, aplikatif, dan berorientasi pada keselamatan ibu serta janin. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB 1 KONSEP DASAR PEMERIKSAAN ANTENATAL TERPADU DAN STANDAR PELAYANAN ANC **1**
A. Pengertian dan Tujuan Pemeriksaan Antenatal Terpadu dan Standar Pelayanan ANC 1
B. Sasaran dan indicator pelayanan antenatal care 2
C. Standar Pelayanan ANC (jadwal, komponen minimal, indikator mutu) sebagai dasar praktik 4
D. Aktivitas 1 — Knows How 6
E. Portofolio 11
F. Rangkuman Materi 16
G. Daftar Pustaka 17

BAB 2 PERSIAPAN PEMERIKSAAN ANC: ALAT, LINGKUNGAN, PRIVASI DAN PENCEGAHAN INFEKSI **19**
A. Persiapan Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) 20
B. Langkah Tindakan Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) 21
C. Aktivitas 1 — Knows How 25
D. Portofolio 29
E. Rangkuman Materi 37
F. Tabel Red Flags & Eskalasi 37
G. Daftar Pustaka 38

BAB 3 PEMERIKSAAN FISIK UMUM: KEPALA–LEHER, JANTUNG–PARU, ABDOMEN NON-OBSTETRI, DAN EKSTREMITAS **41**
A. Teori Dasar 41
B. Defenisi 43
C. Tujuan 44
D. Indikasi 45
E. KontraIndikasi 45
F. Alat 45
G. Persiapan 45

H. Langkah/Tindakan 47
I. Keselamatan Pasien 49
J. Evaluasi Hasil 50
K. Dokumentasi 52
L. Aktivitas 1 — Knows How 53
M. Tabel Red Flags & Eskalasi 58
N. Rangkuman Materi 59
O. Daftar Pustaka 60

BAB 4 PEMERIKSAAN ABDOMEN OBSTETRI: LEOPOLD, TINGGI FUNDUS, PRESENTASI, DAN PENURUNAN BAGIAN TERENDAH 61
A. Palpasi Leopold 62
B. Aktivitas 1 — Knows How 64
C. Portofolio 68
D. Rangkuman Materi 74
E. Daftar Pustaka 75

BAB 5 PENILAIAN KESEJAHTERAAN JANIN: DJJ, GERAK JANIN, DAN PEMANTAUAN PERTUMBUHAN 77
A. DJJ 78
B. Gerak Janin 82
C. Pemantauan Pertumbuhan 86
D. Aktivitas 1 — Knows How 96
E. DOPS 101
F. Portofolio 104
G. Tabel Red Flags & Eskalasi 109
H. Rangkuman Materi 111
I. Daftar Pustaka 112

PROFIL PENULIS 115

BAB 1

KONSEP DASAR PEMERIKSAAN ANTENATAL TERPADU DAN STANDAR PELAYANAN ANC

Uraian Materi

A. Pengertian dan Tujuan Pemeriksaan Antenatal Terpadu dan Standar Pelayanan ANC

Pengertian Pelayanan AntenaTAL Terpadu

Pelayanan antenatal (ANC) mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan sejak pembuahan hingga awal persalinan, yang bertujuan untuk memastikan pelayanan yang komprehensif dan berkualitas bagi semua ibu hamil dan memainkan peran penting dalam menurunkan AKI dengan mengidentifikasi dan mengatasi potensi komplikasi selama persalinan. ANC adalah bentuk perawatan yang bertujuan untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi melalui pemeriksaan rutin. (Setiana, dkk., 2024, Kasmiati, 2023)

Pemeriksaan Antenatal terpadu atau Layanan ANC membantu mempersiapkan ibu hamil untuk menghadapi kehamilan, persalinan, dan menjaga lingkungan yang melindungi bayi dari infeksi. Dokter dan bidan dilatih untuk memberikan ANC yang berkualitas tinggi, melakukan deteksi dini (skrining), mendiagnosis, menangani, dan merujuk kasus, sehingga berkontribusi dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Oleh karena itu, program ANC menjadi indikator kunci keberhasilan petugas kesehatan dalam melindungi ibu hamil, dengan fokus pada identifikasi dini risiko terkait kehamilan (Ariestanti et al., 2020; Setiana, dkk., 2024)

Tujuan pelayanan ANC

Tujuan pelayanan ANC Terpadu Adalah semua ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal yang komprehensif dan berkualitas sehingga ibu hamil dapat menjalani kehamilan dan persalinan dengan pengalaman yang bersifat positif serta melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Pengalaman yang bersifat positif adalah pengalaman yang menyenangkan dan memberikan nilai tambah yang

bermanfaat bagi ibu hamil dalam menjalankan perannya sebagai perempuan, istri dan ibu. (Kemenkes RI Direk Kesmas, 2020; Purnamasari F, 2020)

Selain itu terlaksananya pelayanan antenatal terpadu, termasuk konseling, dan gizi ibu hamil, konseling KB dan pemberian ASI. Terlaksananya dukungan emosi dan psikososial sesuai dengan keadaan ibu hamil pada setiap kontak dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis/kebidanan dan interpersonal yang baik. Setiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu minimal 6 kali selama masa kehamilan. Terlaksananya pemantauan tumbuh kembang janin. Deteksi secara dini kelainan/penyakit/gangguan yang diderita ibu hamil. Dilaksanakannya tatalaksana terhadap kelainan/penyakit/gangguan pada ibu hamil sedini mungkin atau rujukan kasus ke fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai dengan sistem rujukan yang ada. (Kemenkes RI Direk Kesmas, 2020; Sriwidya, 2025)

B. Sasaran dan indicator pelayanan antenatal care

Sasaran Pelayanan Antenatal Terpadu: Seluruh wanita hamil di wilayah Republik Indonesia.

Indikator Pelayanan Antenatal Terpadu (Kemenkes RI Direk Kesmas, 2020; Sriwidya, 2025

1. Kunjungan pertama (K1)

K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis/kebidanan dan interpersonal yang baik, untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama harus dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama, sebaiknya sebelum minggu ke 8. Kontak pertama dapat dibagi menjadi K1 murni dan K1 akses.

K1 murni adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan pada kurun waktu trimester 1 kehamilan. Sedangkan K1 akses adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan pada usia kehamilan berapapun. Ibu hamil seharusnya melakukan K1 murni, sehingga apabila terdapat komplikasi atau factor risiko dapat ditemukan dan ditangani sedini mungkin.

2. Kunjungan ke-4 (K4)

K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis/kebidanan untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu dan komprehensif sesuai standar selama kehamilannya minimal 4 kali dengan distribusi waktu: 1 kali pada trimester pertama (0-12 minggu), 1 kali pada trimester kedua (>12minggu -24 minggu), dan 2 kali pada trimester ketiga

(>24 minggu sampai dengan kelahiran). Kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan (jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan).

3. Kunjungan ke-6 (K6)

K6 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis/kebidanan untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu dan komprehensif sesuai standar selama kehamilannya minimal 6 kali selama kehamilannya dengan distribusi waktu: 2 kali pada trimester kesatu (0-12 minggu), 1 kali pada trimester kedua (>12minggu - 24 minggu), dan 3 kali pada trimester ketiga (>24 minggu sampai dengan kelahiran), dimana minimal 2 kali ibu hamil harus kontak dengan dokter (1 kali di trimester 1 dan 1 kali di trimester 3).

Kunjungan antenatal bisa lebih dari 6 (enam) kali sesuai kebutuhan dan jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan. Jika kehamilan sudah mencapai 40 minggu, maka harus dirujuk untuk diputuskan terminasi kehamilannya. Pemeriksaan dokter pada ibu hamil dilakukan saat : Kunjungan 1 di trimester 1 (satu) dengan usia kehamilan kurang dari 12 minggu atau dari kontak pertama Dokter melakukan skrining kemungkinan adanya faktor risiko kehamilan atau penyakit penyerta pada ibu hamil termasuk didalamnya pemeriksaan *Ultrasonografi* (USG). Apabila saat K1 ibu hamil datang ke bidan, maka bidan

tetap melakukan ANC sesuai standar, kemudian merujuk ke dokter. Kunjungan 5 di trimester 3 Dokter melakukan perencanaan persalinan, skrining faktor risiko persalinan

termasuk pemeriksaan *Ultrasonografi* (USG) dan rujukan terencana bila diperlukan. (Kemenkes RI Direk Kesmas, 2020; Sriwidya, 2025)

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa program dan strategi untuk meningkatkan pengetahuan perempuan dan memperkuat peran mereka dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan, seperti Program Kesiapan Persalinan dan Kesiapan Menghadapi Komplikasi (BPCR) dengan Stiker, Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), dan Program Kelas Ibu Hamil (KIH). Program-program ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan perempuan dalam mengenali tanda-tanda bahaya kehamilan dan persalinan, untuk mempersiapkan perempuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam kasus darurat obstetri. Kurangnya pengetahuan mengenai tanda bahaya kehamilan sering terjadi karena kurangnya kunjungan ANC. Kurangnya kunjungan ANC ini bisa menyebabkan bahaya bagi ibu maupun janin seperti terjadinya perdarahan saat masa

kehamilan karena tidak terdeteksinya tanda bahaya dan rendahnya kunjungan pada antenatal care dapat meningkatkan komplikasi maternal dan neonatal serta kematian ibu dan anak karena adanya kehamilan berisiko tinggi mengalami komplikasi saat kehamilan (perdarahan, preeklamsia, infeksi,) maupun saat persalinan (infeksi saat melahirkan, masalah payudara, perdarahan postpartum, partus macet, ruptur arteri, letak sunsang dan retensio plasenta). Komplikasi kehamilan dapat akan dideteksi lebih dini dengan kunjungan antenatal care. Ibu hamil akan kurang mendapat informasi tentang cara perawatan kehamilan yang benar, Tidak terdeteksinya tanda bahaya kehamilan secara dini, anemia kehamilan yang dapat menyebabkan perdarahan saat persalinan, tanda penyulit persalinan sejak awal seperti kelainan bentuk panggul atau kelainan pada tulang belakang, atau kehamilan ganda, penyakit penyerta dan komplikasi selama kehamilan seperti pre eklampsia, penyakit kronis seperti penyakit jantung, paru dan penyakit karena genetik seperti diabetes, hipertensi, atau cacat kongenital. Oleh karena itu, penyuluhan kesehatan sebagai media edukatif partisipatif diperlukan untuk mengedukasi ibu hamil mengenai ANC. (Lilis, 2025)

C. Standar Pelayanan ANC (jadwal, komponen minimal, indikator mutu) sebagai dasar praktik

WHO (*World Health Organization*) mengeluarkan rekomendasi perawatan antenatal untuk memberikan pengalaman kehamilan yang positif dan mengurangi angka kematian dan kesakitan ibu dan anak. Salah satu rekomendasi WHO adalah bahwa ANC untuk kehamilan yang sehat harus dilakukan setidaknya 8 kali, tetapi setelah menyesuaikan pedoman ini dengan kondisi lokal, disepakati di Indonesia bahwa ANC harus dilakukan setidaknya 6 kali, dengan minimal dua kali kunjungan ke dokter untuk skrining faktor risiko kehamilan atau komplikasi pada trimester pertama dan satu kali kunjungan pada trimester ketiga untuk skrining faktor risiko persalinan. (Setiana, dkk., 2024)

Salah satu inisiatif dari Kementerian Kesehatan Indonesia adalah mewajibkan kunjungan antenatal care (ANC) setidaknya 6 kali selama periode kehamilan 9 bulan, yang menunjukkan komitmen untuk menyediakan layanan penting bagi ibu hamil. Untuk mendukung upaya ini, Kementerian Kesehatan berupaya menyediakan layanan USG di seluruh provinsi di Indonesia. Sebelumnya, USG hanya tersedia di rumah sakit atau klinik, tetapi sekarang ibu hamil juga dapat mengakses pemeriksaan ini di Puskesmas. (Setiana, dkk., 2024).

Standar pelayanan antenatal terpadu minimal adalah 12 T sebagai berikut (Kemenkes RI Direk Kesmas, 2020; Sriwidya, 2025).

1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan
2. Ukur tekanan darah
3. Nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas/LILA)
4. Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri)
5. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)
6. Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan
7. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan
8. Tes laboratorium
9. Tata laksana/penanganan kasus sesuai kewenangan
10. Temu wicara (konseling)
11. Pemeriksaan USG
12. Tes skrining Jiwa

Informasi yang diberikan selama konseling setidaknya mencakup hasil kunjungan, perawatan yang sesuai dengan usia kehamilan dan usia ibu, asupan gizi ibu hamil, kesiapan mental, pengenalan tanda-tanda bahaya selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas, persiapan persalinan, kontrasepsi setelah persalinan, perawatan bayi baru lahir, inisiasi menyusui dini, serta pemberian ASI eksklusif, motivasi hidup sehat (Rinata, 2022).

Tabel 1.1: Kerangka Konsep Pelayanan Antenatal Terpadu

IBU HAMIL	ANC	Masalah gizi	Rujuk penanganan gizi	Yang diharapan setelah ANC ibu hamil adalah 1. Persalinan bersih & aman 2. Perawatan BBL
		Berisiko	Perencanaan persalinan aman di fasilitas kesehatan	
		Komplikasi Kebidanan	Penanganan komplikasi dan persiapan rujukan	
		Penyakit tidak menular	Rujuk penanganan penyakit tidak menular	
		Penyakit menular	Rujuk penanganan penyakit menular	
		Gangguan jiwa	Rujuk penanganan gangguan jiwa	

(Kemenkes RI Direk Kesmas, 2020)

Pelayanan antenatal terpadu adalah diberikan kepada semua ibu hamil dengan cara:

1. Menyediakan kesempatan pengalaman positif bagi setiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu.
2. Melakukan pemeriksaan antenatal pada setiap kontak untuk mengetahui kondisi janin dan ibu serta usia gestasi.
3. Memberikan konseling kesehatan dan gizi ibu hamil, termasuk konseling KB dan pemberian ASI.
4. Memberikan dukungan emosi dan psikososial sesuai dengan kebutuhan/keadaan ibu hamil serta membantu ibu hamil agar tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman selama masa kehamilan dan menyusui.
5. Melakukan pemantauan tumbuh kembang janin.
6. Mendeteksi secara dini kelainan/penyakit/gangguan yang diderita ibu hamil.
7. Melakukan tatalaksana terhadap kelainan/penyakit/gangguan pada ibu hamil sedini mungkin atau melakukan rujukan kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem rujukan.
8. Mempersiapkan persalinan yang bersih dan aman.
9. Melakukan rencana antisipasi dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi penyulit/komplikasi pada proses persalinan.
10. Melakukan tatalaksana kasus serta rujukan tepat waktu pada kasus kegawatdaruratan maternal neonatal.
11. Melibatkan ibu hamil, suami dan keluarga dalam menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil, mempersiapkan persalinan dan kesiagaan apabila terjadi komplikasi. (Kemenkes RI Direk Kesmas, 2020)

D. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang perempuan umur 28 tahun G1P0A0, ini merupakan kunjungan ke 2 tanggal 27 Maret 2026, HPHT ibu 13 Januari 2026, datang ke PMB dengan keluhan mual muntah dan pusing sehingga membuat ibu sulit beraktifitas dan mudah Lelah dan kadang nangis merasa tidak sanggup dengan keadaan. Hasil Anamnesis: mual muntah terus menerus, tidak nafsu makan, dan nyeri epigastrium. Hasil Pemeriksaan: TD 90/60 mmHg, N 90 x/menit, S 38,5 ℃, P 18 x/menit, lidah kering, turgor kulit berkurang, Hb 7 mmHg, BB sekrang 45 kg, TB 158 cm, Lila 22 cm.

Pertanyaan diskusi

1. Berapa gestasi ibu / usia kandungan ibu menurut rumus neagle?

2. Kunjungan pemerikasaan sesuai kasus masuk pada kunjungan (K) keberapa sesuai trimester?
3. Apa perubahan fisiologi yang dirasakan ibu selama hamil dan apa masuk kategori fisiologi atau patologi?
4. Apa perubahan psikologis yang dirasakan ibu selama hamil dan apa masuk kategori fisiologi atau patologi?
5. Pemeriksaan apa saja yang secara head to toe maupun pemeriksaan laboratorium dan penunjang sesuai kasus diatas?
6. Apa saja diagnose yang sesuai dengan kasus di atas di tinjau dari mual muntah, IMT, dan Hb ibu?
7. Apa penatalaksanaan atau intervensi yang sesuai kasus di atas dari mual muntah, IMT, dan Hb ibu?

TEMPLATE SOAL OSCE

1.	Nomor stasi	02/01
2.	Judul stasi	Asuhan Kebidanan Kehamilan dengan Pemeriksaan fisik TM I
3.	Waktu yang dibutuhkan	10 menit (1 menit akan digunakan untuk membaca soal, 9 menit digunakan untuk mengerjakan soal)
4.	Tujuan stasi	Peserta ujian mampu melakukan Pemeriksaan fisik TM I
5.	Kompetensi	**1. Anamnesis** **2. Pemeriksaan fisik dan/atau pemeriksaan penunjang** 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Tindakan klinis 5. KIE/Konseling 6. Kolaborasi/Rujukan **7. Pendokumentasian** **8. Perilaku profesional**
6.	Kategori (ditebalkan sesuai blue print)	1. Masa Antara/prakonsepsi: normal/deteksi dini 2. Kehamilan Normal 3. Kehamilan: Deteksi Dini/Gadar 4. Persalinan: Normal 5. Persalinan: Deteksi Dini/Gadar 6. Nifas/Masa Laktasi: Normal/Deteksi Dini 7. Neonatus sd. 28 hari: Normal/Deteksi Dini/Gadar 8. Keluarga Berencana: Normal/Deteksi dini

7.	Instruksi peserta ujian	**Skenario klinik:** Seorang perempuan berumur 24 tahun datang ke TPMB untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis yaitu haid terakhir 3 bulan yang lalu. Ibu telah tespack dirumah positif hamil. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mmHg, N 80x/menit, P 20x/menit, S 36,4°C, payudara bersih, puting menonjol, TFU belum teraba, DJJ (denyut jantung janin) belum teraba. **Tugas:** 1. Melakukan ananmesis kepada pasien 2. Melaksanakan pemeriksaan fisik TM 1 pada phantom 3. Melakukan pendokumentasi hasil pemeriksaan fisik
8.	Instruksi penguji	**Skenario klinik:** Seorang perempuan berumur 24 tahun datang ke TPMB untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis yaitu haid terakhir 3 bulan yang lalu. Ibu telah tespack di rumah positif hamil. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mmHg, N 80x/menit, P 20x/menit, S 36,4°C, payudara bersih, puting menonjol, TFU dan DJJ (denyut jantung janin) belum teraba. **Tugas:** 1. Melakukan ananmesis kepada pasien 2. Melaksanakan pemeriksaan fisik TM 1 pada phantom 3. Melakukan pendokumentasi hasil pemeriksaan fisik **Instruksi umum untuk penguji** 1. Tulislah nama peserta pada kolom penilaian sesuai rotasi masuk! 2. Amati peserta mengacu pada rubrik penilaian dan berikan nilai skor actual mark (0/1/2/3) 3. Berikan nilai global performance/global rating (tidak lulus/borderline/lulus/superior) 4. Tidak boleh melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE 6. Merapihkan stasi dan alat diantara pergantian peserta

		<u>Instruksi khusus</u>: Tidak ada **Tugas Tambahan:** Membantu merapikan kembali alat
10	Kebutuhan dan interaksi /scenario pemeran simulasi	**Kebutuhan PS: Tidak ada** **Skenario PS: tidak ada**
11	Tipe Ruangan	1 (Ruang tindakan)
12	Kebutuhan laboran (dalam station)	Tidak ada **Tugas laboran:** Tidak ada
13	Kebutuhan manekin	Manekin ibu hamil full body
14	Kebutuhan alat	Timbangan BB Tensimeter Stetoskop Termometer Meteran/pita cm Pengukur TB Pengukur lingkar lengan atas (LILA) Pengukur tinggi fundus uteri Doppler/ lenek Jelly Hummer untuk memeriksa refleks Waskom Larutan clorin 0,5% Sarung tangan Buku KIA pulpen Handuk kecil
15	Penulis	Feby Purnamasari, S.ST., M.Keb

16	Referensi	Tutik Iswanti, dkk, 2022, Sukses Ukom DIII Bidan, PT Nuansa Fajar Cemerlang Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F JL. S. Parman Kav 22-24, Palmerah, Jakarta Barat Purnamasari F., 2020, Buku Ajar Asuhan Kebidana Kehamilan, CV. Nas Media Pustaka, Makassar, Hal. 1-160

Rubrik Penilaian Station 02/01

NO	Skor / Kompetensi	0	1	2	3	BOBOT (1-3)	SKOR MAKS (Skor tertinggi x Bobot)
1	Anamnesis	Hanya menanyakan identitas berupa nama pasien	Peserta ujian hanya mampu menunjukkan **2 dari 4 anamnesis** dibawah ini : 1. Apa keluhannya ibu 2. HPHT 3. Gestasi Paritas Abortus 4. Riwayat penyakit ibu	Peserta ujian hanya mampu menunjukkan **3 dari 4 ananmesis** dibawah ini : 1. Apa keluhannya ibu 2. HPHT 3. Gestasi Paritas Abortus 1. Riwayat penyakit ibu	Peserta ujian hanya mampu menunjukkan **4 ananmesis** dibawah ini : 1. Apa keluhannya ibu 2. HPHT 3. Gestasi Paritas Abortus 4. Riwayat penyakit ibu	2	6
2	Pmeriksaan fisik TM 1	Peserta ujian **tidak mampu** melakukan: 1. Informen consent 2. Pemeriksaan kepala hingga payudara 3. leopold 4. Pemeriksaan ekstrenitas atas bawah	Peserta ujian hanya mampu menunjukkan **2 dari 4** melakukan: 1. Informen consent 2. Pemeriksaan kepala hingga payudara 3. leopold 4. Pemeriksaan ekstrenitas atas bawah	Peserta ujian hanya mampu menunjukkan **3 dari 4** melakukan: 1. Informen consent 2. Pemeriksaan kepala hingga payudara 3. leopold 4. Pemeriksaan ekstrenitas atas bawah	Peserta ujian hanya mampu menunjukkan **4** melakukan: 1. Informen consent 2. Pemeriksaan kepala hingga payudara 3. leopold 4. Pemeriksaan ekstrenitas atas bawah	3	9
3	Pendokumentasian	Peserta ujian **tidak mampu** memberikan konseling dengan tepat seperti dibawah ini: 1. Menuliskan data subjektif 2. Menuliskan data objektif 3. Menuliskan Analisa, 4.	Peserta ujian hanya mampu menunjukkan **1 dari 3** memberikan dokuemntasi dengan tepat seperti dibawah ini: 1. Menuliskan data subjektif 2. Menuliskan data objektif 3. Menuliskan	Peserta ujian hanya mampu menunjukkan **2 dari 3** memberikan dokuemntasi dengan tepat seperti dibawah ini: 1. Menuliskan data subjektif 2. Menuliskan data objektif 3.	Peserta ujian hanya mampu menunjukkan **3** memberikan dokuemntasi dengan tepat seperti dibawah ini: 1. Menuliskan data subjektif 2.	3	9

NO	Skor / Kompetensi	0	1	2	3	BOBOT (1-3)	SKOR MAKS (Skor tertinggi x Bobot)
		Menuliskan perencanaan tindakan	Analisa, 4. Menuliskan perencanaan tindakan	Menuliskan Analisa, 4. Menuliskan perencanaan tindakan	Menuliskan data objektif, 3. Menuliskan Analisa, 4. Menuliskan perencanaan tindakan		
4	Perilaku profesional	Peserta ujian **tidak mampu menunjukkan atau hanya 1 dari 4 perilaku professional** dibawah ini: Informed consent Menerapkan prinsip pencegahan infeksi Bersikap hati-hati dan memastikan pasien nyaman Menerapkan prinsip dokumentasi	Peserta ujian hanya mampu menunjukkan **2 dari 4 perilaku professional** dibawah ini: 1. Informed consent 2. Menerapkan prinsip pencegahan infeksi 3. Bersikap hati hati dan memastikan pasien nyaman 4. Menerapkan prinsip dokumentasi	Peserta ujian hanya mampu menunjukkan 3 dari **4 perilaku professional** dibawah ini: 1. Informed consent 2. Menerapkan prinsip pencegahan infeksi 3. Bersikap hati hati dan memastikan pasien nyaman 4. Menerapkan prinsip dokumentasi	Peserta ujian mampu menunjukkan **4 perilaku professional** dibawah ini: 1. Informed consent 2. Menerapkan prinsip pencegahan infeksi 3. Bersikap hati hati dan memastikan pasien nyaman 4. Menerapkan prinsip dokumentasi	2	6

E. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Pemeriksaan Antenatal Terpadu: Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, dan Interpretasi dalam hal Konsep Dasar Pemeriksaan Antenatal Terpadu dan Standar Pelayanan ANC

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam	Pada topik anamnesis, pemeriksaan fisik pada pasien ibu hamil, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
	OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	mulai dari identifikasi data dasar / anamesis di lanjut pemeriksaan fisik baik head to toe, laboratorium, penunjang, dan sesuai keluhan kemudian interpretasi guna memantau tumbuh kembamg janin, dan keadaan ibu hamil, serta deteks dini ada masalah pada janin atau ibu hamil dan rencana tindakan.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu hamil dengan keluhan, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan interpretasi pematauan tumbuh kembang janin, keadaan ibu hamil, deteksi dini, dan tindakan awal pra-rujukan. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penilaian ibu hamil, stabilisasi awal, dan persiapan rujukan pada kasus ibu hamil dengan masalah patologi selama kehamilan.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus ibu G1P0A0 usia kehamilan 10 minggu dengan hyperemesis, anemia, dan KEK (Kekurangan Energi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
		Kronik), tindakan awal yang dilakukan, dan keputusan rujukan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya tidak menunda pengenalan deteksi dini, ketelitian dalam mengkaji anamesis, pemeriksaan fisik, penentuan diagnose sesuai keluhan dan pemeriksaan, pencegahan keterlambatan rujukan, dan komunikasi cepat dengan keluarga pada kasus patologis dalam kehamilan.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengenali deteksi dini dan menjelaskan rujukan, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam menilai anamnesis, keluhan, pemeriksaan fisik, dan diagnosis, dan ketegasan saat melakukan intervensi dan jika ada kolaborasi.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus hyperemesis, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menilai anemia, mengenali gizi KEK atau masalah lain, dan melakukan tindakan awal secara aman.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu menggunakan anamesis, keluhan, pemeriksaan fisik, diagnosis, mengenali tanda bahaya, dan mengambil keputusan awal yang tepat pada kehamilan bermasalah.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik kehamilan normal maupun kehamilan dengan indikasi masalah ibu dan janin, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Ibu Hamil gestasi 10 minggu dengan Hyperemesis, Anemia dan KEK (Kekurangan Energi Kronik)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus ibu hamil hyperemesis, Anemia dan KEK mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali deteksi dini tanda bahaya kehamilan.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa deteksi dini tanda bahaya kehamilan, seperti hyperemesis, Anemia dan KEK, pendaharan, pusing, Oedema ekstrenitas, penglihatan kabur/buram, dan lain-lain.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini Adalah masalah pada ibu dan janin sampai pada kelahiran dengan penyulit. Jika tidak di tangani dengan benar.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain keterlambatan diagnosis maka janin mengalami keterlambatan tumbuh kembang, bblr, fetal distress, KJDR (Kematian Janin Dalam Rahim), Ibu pendarahan, syok, dan lainnya jika tidak di tangani dengan benar, dan keterlambatan rujukan.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya penggunaan anamesis, penentuan keluhan, pemeriksaan fisik, dan intervensi yang sesuai, komunikasi cepat kepada keluarga, dan rujukan tepat waktu ke fasilitas yang lebih mampu.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa	Mahasiswa menyadari bahwa pada ibu hamil yang bermasalah,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
	dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	pengkajian serial, pengambilan keputusan cepat, dan keberanian melakukan eskalasi adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap 16rofessional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

F. Rangkuman Materi

Dokter dan bidan dilatih untuk memberikan ANC yang berkualitas tinggi, melakukan deteksi dini (skrining), mendiagnosis, menangani, dan merujuk kasus, sehingga berkontribusi dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Oleh karena itu, program ANC menjadi indikator kunci keberhasilan petugas kesehatan dalam melindungi ibu hamil, dengan fokus pada identifikasi dini risiko terkait kehamilan.

Salah satu rekomendasi WHO adalah bahwa ANC untuk kehamilan yang sehat harus dilakukan setidaknya 8 kali, tetapi setelah menyesuaikan pedoman ini dengan kondisi lokal, disepakati di Indonesia bahwa ANC harus dilakukan setidaknya 6 kali, dengan minimal dua kali kunjungan ke dokter untuk skrining faktor risiko kehamilan atau komplikasi.

G. Daftar Pustaka

Cholifah, S., & Rinata, E., (2022). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan. *Pers Umsida* , 1–243. https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-045-8

Kasmiati., (2023), *Asuhan Kehamilan. Asuhan Kehamilan*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang.

Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, (2020)., *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. ISBN 978-602-416-974-9

Kementrian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Bagi Ibu Hamil, Ibu nifas, dan Bayi Baru Lahir. Pedoman Bagi Ibu Hamil , Ibu Nifas Dan Bayi Baru Lahir Selama Selama Social Distancing, Kemenkes*.

Lilis A.H., Yuniar, Ranisri L., Nurmila, Nurlaela A., Gede S., Mikawati, (2025), Edukasi Antenatal Care (ANC) Dalam Upaya Pencegahan Komplikasi Kehamilan Pada Ibu Hamil**,** Jannah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 01 (02), *pp, 87-93* https://jurnal.mifandimandiri.com/index.php/jannah, ISSN (*Online*) 3090-6636

Purnamasari F., 2020, Buku Ajar Asuhan Kebidana Kehamilan, CV. Nas Media Pustaka, Makassar, Hal. 1-160

Setiana A., Setiawandari, Tetty R., Solichatin, Yuni K.W., (2024), Edukasi Kesehatan Tentang Pemeriksaan Antenatal Care Berbasis Komunitas, *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, ISSN (Online): 21008-3407, DOI: 10.59818/jpm.v4i6.998, Vol. 4 (6)

Sriwidya A.K., Adelia N., (2025), Hubungan Usia dan Paritas Ibu Hamil dengan Kelengkapan Pemeriksaan Antenatal *Care* (ANC) di Desa Kualu Wilayah Kerja Puskesmas Tambang Kabupaten Kampar, Corona Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan dan Kebidanan, Vol. 3 (1), e-ISSN : 3031-0172; dan p-ISSN : 3031-0180; Hal. 174-190 DOI: https://doi.org/10.61132/corona.v3i1.1120

BAB 2

PERSIAPAN PEMERIKSAAN ANC: ALAT, LINGKUNGAN, PRIVASI DAN PENCEGAHAN INFEKSI

CPL-1: Menguasai Konsep Ilmiah Dan Evidence-Based Terkait Pemeriksaan Antenatal Terpadu.

CPMK-1

Menganalisis konsep dasar pemeriksaan antenatal terpadu, standar pelayanan ANC, serta prinsip privasi, keselamatan pasien, dan pencegahan infeksi.

Sub CPMK 1: Mengidentifikasi komponen dan tahapan pemeriksaan antenatal terpadu sesuai standar pelayanan ANC

Sub CPMK 2: Menjelaskan prinsip privasi dan kerahasiaan dalam pelayanan antenatal.

Sub CPMK 3: Mengidentifikasi penerapan prinsip keselamatan pasien pada pelayanan ANC.

Sub CPMK 4: Menjelaskan penerapan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi dalam pemeriksaan ANC

Aktivitas Belajar (Scaffolding)

Pendahuluan

Persiapan Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan pemeriksaan kehamilan untuk memastikan ibu hamil siap secara fisik, psikologis, administrasi, serta tersedianya alat dan lingkungan yang aman sehingga pemeriksaan dapat berlangsung efektif, nyaman, dan sesuai standar pelayanan kebidanan. Tujuannya untuk memastikan pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan secara **aman, efektif, nyaman, dan mendapatkan hasil yang akurat** bagi ibu hamil maupun tenaga kesehatan.

Ibu hamil yang datang untuk pemeriksaan kehamilan biasanya karena kunjungan pertama kehamilan (K1), pemeriksaan berkala sesuai usia kehamilan dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan janin serta adanya keluhan selama kehamilan.

Kondisi atau keadaan tertentu yang **tidak memungkinkan atau perlu menunda pelaksanaan pemeriksaan ANC tertentu** karena dapat membahayakan ibu hamil maupun janin, misalnya Perdarahan Per Vaginam, Nyeri Abdomen Hebat, Ketuban Pecah Dini (KPD), Tanda Infeksi Berat, Preeklamsia Berat / Eklampsia, Kondisi Gawat Darurat Obstetri. Dalam pelayanan ANC berlaku prinsip Keselamatan ibu dan janin lebih diutamakan dibandingkan dengan kelengkapan pemeriksaan.

Uraian Materi

A. Persiapan Pemeriksaan Antenatal Care (ANC)

1. Persiapan Petugas Kesehatan (Bidan/Tenaga Medis)

a. Sikap dan Perilaku
   1) Memberikan salam dan memperkenalkan diri
   2) Menjelaskan tujuan pemeriksaan ANC yang akan dilakukan
   3) Menjelaskan prosedur yang akan dilaksanakan
   4) Memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya
   5) Meminta persetujuan *(informed consent)* sebelum pemeriksaan dilakukan
   6) Memposisikan pasien dengan baik
   7) Tanggap terhadap reaksi pasien
   8) Sabar dan teliti
   9) Menjalin kerja sama dan hubungan saling percaya dengan pasien

b. Persiapan
   1) Tempat pemeriksaan yang nyaman, tenang, bersih dan aman
   2) Pemeriksa
      a) Mencuci tangan 6 langkah sebelum tindakan
      b) Pemeriksaan Menggunaan APD Level 2
      c) Pemeriksa dalam keadaan tenang
      d) Menjaga privasi pasien selama pemeriksaan

2. Persiapan Alat dan Bahan

a. Alat pemeriksaan umum
   1) Tensimeter dan stetoskop
   2) Termometer
   3) Timbangan berat badan
   4) Pengukur tinggi badan
   5) Jam tangan (menghitung nadi/napas)

b. Alat pemeriksaan kebidanan
   1) Doppler / fetoskop
   2) Meteran (pengukur tinggi fundus uteri)
   3) Sarung tangan bersih
   4) Jelly pelumas (jika diperlukan)

c. Bahan penunjang
   1) Buku KIA / rekam medis

2) Formulir pemeriksaan ANC
3) Alat tulis

3. Persiapan Lingkungan

Lingkungan pemeriksaan harus:

a. Bersih dan nyaman
b. Memiliki pencahayaan cukup
c. Menjaga privasi ibu (tirai/ruang tertutup)
d. Ventilasi baik
e. Tempat tidur/periksa siap digunakan

4. Persiapan Ibu Hamil

Sebelum pemeriksaan dilakukan:

a. Ibu diberi penjelasan tentang prosedur pemeriksaan
b. Ibu dianjurkan:
   1) Buang air kecil terlebih dahulu
   2) Menggunakan pakaian yang mudah diperiksa
   3) Membawa buku KIA
c. Membina hubungan saling percaya (komunikasi efektif)

5. Persiapan Administrasi

a. Identifikasi pasien
b. Pengisian data ibu hamil
c. Riwayat kesehatan dan kehamilan
d. Persiapan pencatatan hasil pemeriksaan

B. Langkah Tindakan Pemeriksaan Antenatal Care (ANC)

Standar pelayanan antenatal terpadu minimal adalah sebagai berikut (Kemenkes RI, 2010):

No	Komponen 10 T	Tujuan
1	Timbang berat badan dan ukur tinggi badan	Menilai status gizi ibu dan risiko kehamilan
2	Ukur tekanan darah	Mendeteksi hipertensi dalam kehamilan dan preeklamsia
3	Ukur Lingkar Lengan Atas (LiLA)	Mendeteksi risiko Kurang Energi Kronis (KEK).
4	Ukur Tinggi Fundus Uteri (TFU)	Menilai pertumbuhan dan usia kehamilan janin.
5	Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ	Menilai kondisi dan kesejahteraan janin.
6	Pemberian/Skrining status imunisasi Tetanus Toksoid (TT)	Mencegah tetanus maternal dan neonatal.

	dan berikan imunisasi tetanus difteri (TD) bila diperlukan	
7	Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD/Fe) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Mencegah dan mengatasi anemia pada ibu hamil.
8	Tes Laboratorium	Tes kehamilan, kadar hemoglobin darah, golongan darah, tes triple eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis B) dan malaria pada daerah endemis. Tes lainnya dapat dilakukan sesuai indikasi seperti: gluko-protein urin, gula darah sewaktu, sputum Basil Tahan Asam (BTA), kusta, malaria daerah non endemis, pemeriksaan feses untuk kecacingan, pemeriksaan darah lengkap untuk deteksi dini thalasemia dan pemeriksaan lainnya
9	Tatalaksana kasus	Penanganan atau rujukan bila ditemukan masalah atau faktor risiko.
10	Temu wicara (konseling)	Informasi yang disampaikan saat konseling minimal meliputi hasil pemeriksaan, perawatan sesuai usia kehamilan dan usia ibu, gizi ibu hamil, kesiapan mental, mengenali tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas, persiapan persalinan, kontrasepsi pascapersalinan, perawatan bayi baru lahir, inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif.

1. Persiapan
   a. Menyiapkan alat dan bahan pemeriksaan
   b. Mencuci tangan sesuai prosedur
   c. Menggunakan APD (masker, sarung tangan bila perlu)
   d. Menyiapkan ruang pemeriksaan yang nyaman dan privasi ibu terjaga
   e. Menjelaskan prosedur kepada ibu dan meminta persetujuan
2. Anamnesis (Pengkajian Data Ibu)
   Melakukan wawancara untuk memperoleh informasi:
   a. Identitas ibu
   b. Riwayat kehamilan sekarang (HPHT, keluhan)
   c. Riwayat obstetri sebelumnya (GPA)
   d. Riwayat penyakit dahulu dan sekarang
   e. Riwayat penggunaan obat
   f. Pola nutrisi, istirahat, aktivitas
   g. Riwayat sosial dan psikologis

3. Pemeriksaan Umum
    a. Keadaan umum ibu
    b. Kesadaran
    c. Berat badan dan tinggi badan
    d. Indeks Massa Tubuh (IMT)
    e. Tekanan darah
    f. Nadi
    g. Respirasi
    h. Suhu tubuh
    i. Lingkar Lengan Atas (LILA)
4. Pemeriksaan Fisik
    a. Pemeriksaan Head to Toe
        1) Kepala dan wajah (edema, pucat)
        2) Mata
        3) Mulut dan gigi
        4) Payudara (persiapan laktasi)
        5) Ekstremitas (edema, varises)
    b. Pemeriksaan Obstetri (Abdomen)
        1) Inspeksi abdomen
        2) Palpasi Leopold I–IV untuk:
            a. Menentukan tinggi fundus uteri
            b. Letak dan posisi janin
            c. Presentasi janin
        3) Auskultasi denyut jantung janin (DJJ)
5. Pemeriksaan Penunjang
    a. Pemeriksaan Hb
    b. Golongan darah
    c. Protein urin
    d. Gula darah sewaktu
    e. HIV
    f. Sifilis
    g. Hepatitis B
    h. Tes laboratorium lainnya sesuai indikasi
    i. Hasil USG
6. Penilaian Status Kehamilan
    a. Menentukan usia kehamilan
    b. Menilai pertumbuhan janin
    c. Identifikasi faktor risiko atau komplikasi

7. Tatalaksana dan Pelayanan
    a. Pemberian tablet Fe
    b. Imunisasi TT sesuai jadwal
    c. Penanganan keluhan ibu
    d. Rujukan bila ditemukan risiko tinggi
8. Konseling dan Edukasi

    Memberikan informasi tentang:
    a. Nutrisi ibu hamil
    b. Tanda bahaya kehamilan (trimester I, II, III)

        Trimester I (0–12 Minggu)

        Ibu harus segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami:
        1) Perdarahan dari jalan lahir.
        2) Nyeri perut hebat.
        3) Mual muntah berlebihan hingga tidak dapat makan dan minum.
        4) Demam tinggi.
        5) Pusing berat atau pingsan

        Trimester II (13–27 Minggu)

        Ibu harus segera mencari pertolongan apabila mengalami:
        1) Perdarahan dari jalan lahir.
        2) Nyeri perut hebat atau kontraksi sebelum waktunya.
        3) Keluar cairan dari jalan lahir.
        4) Demam tinggi.
        5) Gerakan janin berkurang atau tidak dirasakan.

        Trimester III (28–40 Minggu)

        Ibu harus segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami:
        1) Perdarahan dari jalan lahir.
        2) Sakit kepala hebat yang tidak hilang dengan istirahat.
        3) Pandangan kabur.
        4) Bengkak pada wajah dan tangan.
        5) Nyeri ulu hati yang hebat.
        6) Kejang.
        7) Keluar cairan ketuban sebelum waktunya.
        8) Gerakan janin berkurang atau tidak ada.
        9) Kontraksi yang tidak normal atau tanda persalinan prematur.
    c. Persiapan persalinan
    d. Perawatan payudara
    e. Istirahat dan aktivitas
    f. Jadwal kunjungan ulang

9. Dokumentasi
   Mencatat hasil pemeriksaan pada:
   a. Buku KIA
   b. Rekam medis

C. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang perempuan usia 28 tahun, G2P1A0, datang ke klinik bidan untuk pemeriksaan ANC pada usia kehamilan sekitar 30 minggu. Ibu datang bersama suaminya dan mengeluhkan pusing sejak 2 hari terakhir serta bengkak pada kedua kaki. Saat tiba di ruang pemeriksaan, mahasiswa bidan akan melakukan persiapan pemeriksaan ANC.

Hasil observasi awal:

1. Ibu tampak sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik.
2. Ruang pemeriksaan sedang ramai dan tirai pembatas belum ditutup.
3. Alat ANC tersedia, tetapi sebagian belum ditata pada meja tindakan.
4. Mahasiswa belum melakukan mencuci tangan.
5. Identitas pasien belum diverifikasi.
6. Belum dilakukan penjelasan prosedur maupun informed consent.

Pertanyaan

1. Data apa saja yang perlu dikumpulkan sebelum memulai pemeriksaan ANC?
2. Risiko apa yang mungkin sedang dialami ibu berdasarkan keluhan pusing dan bengkak pada kaki?
3. Mengapa verifikasi identitas pasien perlu dilakukan sebelum pemeriksaan?
4. Identifikasi aspek keselamatan pasien yang belum terpenuhi pada kasus di atas!
5. Identifikasi prinsip Respectful Maternity Care (RMC) yang belum diterapkan!
6. Mengapa kebersihan tangan harus dilakukan sebelum kontak dengan pasien?

Template Soal OSCE Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	**Persiapan Pemeriksaan ANC**
3	Kasus	**Persiapan Pemeriksaan ANC: Alat, Lingkungan, Privasi dan Pencegahan Infeksi**

No.	Komponen	Isi
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. **Prosedur tindakan klinis** 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. **Perilaku profesional**
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang ibu hamil, usia 25 tahun, G1P0A0, hamil 28 minggu, datang ke Puskesmas untuk melakukan kunjungan ulang. Hasil anamnesis : ibu mengeluh sudah 1 minggu nyeri punggung. Bidan bertugas melakukan persiapan pemeriksaan fisik secara komprehensif. TUGAS 1. Lakukan persiapan lingkungan yang nyaman dan menjaga *privacy* pasien. 2. Lakukan persiapan alat pemeriksaan ANC. 3. Terapkan pencegahan infeksi dengan pasien. 4. Lakukan perilaku Profesional.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian:

No.	Komponen	Isi
		- Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 2. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS berperan sebagai ibu hamil 28 minggu. 2. PS mengeluh sudah 1 minggu nyeri punggung. 3. Bila peserta memberikan pertanyaan, PS merespons kooperatif. 4. Bila peserta menyampaikan akan persiapkan terlebih dahulu ruangan, tempat, alat dan bahan untuk pemeriksaan, bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia.

No.	Komponen	Isi
		Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Saya ada keluhan nyeri punggung Peserta: Sejak kapan nyeri punggungnya? PS: Kira-kira 1 minggu, Bu. Peserta: Apakah sudah dilakukan pengobatan selama nyeri punggung? PS: belum bu. Peserta: Baik Bu, saya persiapkan terlebih dahulu ruangan, tempat, alat dan bahan untuk pemeriksaan Bu. PS: Baik Bu.
10	Kebutuhan manikin	-Phantom abdomen hamil/manekin Leopold
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manekin - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
13	Penulis	Frani Mariana
14	Referensi	1. Agustini, dkk. 2020. *Asuhan Kebidanan Kehamilan. Jawa Barat* : Media Sains Indonesia 2. Soare dkk. 2025. *buku ajar asuhan kebidanan pada kehamilan*. Pekan Baru: Angkasa Media 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelayanan antenatal terpadu* (Edisi III). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. ISBN 978-602-416-974-9 4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 2024*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI 5. World Health Organization. (2016). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. Geneva: World Health Organization. ISBN 978-92-4-154991-2

D. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Persiapan Pemeriksaan ANC: Alat, Lingkungan, Privasi dan Pencegahan Infeksi

Komponen	Deskripsi	Contoh Persiapan Pemeriksaan ANC: Alat, Lingkungan, Privasi dan Pencegahan Infeksi
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik Persiapan Pemeriksaan ANC, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan persiapan Alat, Lingkungan, Privasi dan Pencegahan Infeksi berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah melakukan persiapan Alat, Lingkungan, Privasi dan Pencegahan Infeksi pada pemeriksaan ANC, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.

Komponen	Deskripsi	Contoh Persiapan Pemeriksaan ANC: Alat, Lingkungan, Privasi dan Pencegahan Infeksi
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan interpretasi dalam persiapan pemeriksaan ANC. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan persiapan Alat, Lingkungan, Privasi dan Pencegahan Infeksi pada pemeriksaan ANC
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus persiapan pemeriksaan ANC: Alat, Lingkungan, Privasi dan Pencegahan Infeksi pada kunjungan ibu hamil 28 minggu G1P0A0 dengan nyeri punggung.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya Refleksi patient safety pada persiapan pemeriksaan ANC bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan dilakukan dengan aman, tepat, higienis, menjaga privasi pasien, serta meminimalkan risiko kesalahan dan infeksi.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam Persiapan Alat, lingkungan, privasi pasien dan pencegahan infeksi, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian

Komponen	Deskripsi	Contoh Persiapan Pemeriksaan ANC: Alat, Lingkungan, Privasi dan Pencegahan Infeksi
		dalam persiapan pemeriksaan ANC.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus persiapan pemeriksaan ANC, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan persiapan pemeriksaan ANC yang mencakup persiapan alat, lingkungan, Privasi pasien dan pencegahan infeksi
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik persiapan pemeriksaan ANC dan portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel. Case Report pada Persiapan Pemeriksaan ANC: Alat, Lingkungan, Privasi dan Pencegahan Infeksi

Komponen	Deskripsi	Contoh Persiapan Pemeriksaan ANC: Alat, Lingkungan, Privasi dan Pencegahan Infeksi
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang Persiapan Pemeriksaan ANC: Alat, Lingkungan, Privasi dan Pencegahan Infeksi
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan Persiapan Pemeriksaan ANC: Alat, Lingkungan, Privasi dan Pencegahan Infeksi
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan persiapan alat seperti kelengkapan alat, kebersihan, kerapian, keterjangkauan alat dan fungsi alat sebelum digunakan. Persiapan lingkungan seperti ruangan bersih, nyaman, dan cukup pencahayaan, suasana tenang dan kondusif untuk pemeriksaan, tempat tidur/periksa siap digunakan, lingkungan mendukung keamanan dan kenyamanan ibu hamil. Menjaga privasi pasien seperti menutup tirai atau pintu saat pemeriksaan, memastikan bagian tubuh pasien yang tidak diperiksa tetap tertutup, menjelaskan prosedur kepada pasien sebelum pemeriksaan, menghormati martabat dan kenyamanan pasien. Pencegahan Infeksi seperti cuci tangan sebelum dan sesudah pemeriksaan, menggunakan APD yang sesuai (misalnya sarung tangan jika

Komponen	Deskripsi	Contoh Persiapan Pemeriksaan ANC: Alat, Lingkungan, Privasi dan Pencegahan Infeksi
		diperlukan), menggunakan alat bersih/steril, membuang limbah medis pada tempat yang benar, menjaga kebersihan alat dan lingkungan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan Persiapan Alat, lingkungan, privasi pasien dan pencegahan infeksi
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus persiapan pemeriksaan ANC, pembelajaran yang diperoleh mahasiswa adalah menyiapkan segala sesuatu sebelum melakukan pemeriksaan pada ibu hamil. Kegiatan ini memberikan pengalaman belajar yang penting dalammeningkatkan kompetensi pelayanan kesehatan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	laporan reflektif yang mendokumentasikan pengalaman mahasiswa dalam menyiapkan pemeriksaan ibu hamil, dengan tujuan untuk menilai **pencapaian kompetensi, penerapan patient safety, serta pengembangan keterampilan dan sikap profesional dalam pelayanan kesehatan.**

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Persiapan Pemeriksaan ANC: Alat, Lingkungan, Privasi dan Pencegahan Infeksi

Komponen	Deskripsi	Contoh Persiapan Pemeriksaan ANC: Alat, Lingkungan, Privasi dan Pencegahan Infeksi
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa	Pada kasus partus lama, mahasiswa merefleksikan bahwa Persiapan pemeriksaan ANC penting untuk **menjamin**

Komponen	Deskripsi	Contoh Persiapan Pemeriksaan ANC: Alat, Lingkungan, Privasi dan Pencegahan Infeksi
	mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	**keselamatan ibu dan janin, mencegah infeksi, menjaga kenyamanan pasien, serta memastikan pemeriksaan berjalan lancar dan sesuai standar pelayanan kesehatan**
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	untuk membantu mahasiswa mengevaluasi dan memahami proses persiapan pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa Fokus refleksi mahasiswa dalam persiapan pemeriksaan ANC meliputi **kesiapan alat, lingkungan, privasi pasien, pencegahan infeksi, keselamatan pasien, serta sikap profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil**.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	isiko yang dapat diidentifikasi dalam persiapan pemeriksaan ANC meliputi **alat yang tidak siap, risiko infeksi, kesalahan identifikasi pasien, kurangnya privasi, lingkungan yang tidak nyaman, serta komunikasi yang kurang baik dengan pasien.** Identifikasi risiko ini penting untuk meningkatkan **patient**

Komponen	Deskripsi	Contoh Persiapan Pemeriksaan ANC: Alat, Lingkungan, Privasi dan Pencegahan Infeksi
		safety dan kualitas pelayanan antenatal.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Tindakan pencegahan dalam persiapan pemeriksaan ANC meliputi **menyiapkan alat dengan benar, menerapkan pencegahan infeksi, melakukan identifikasi pasien, menjaga privasi, menyiapkan lingkungan yang aman, serta memberikan penjelasan kepada pasien** agar pemeriksaan berjalan dengan aman dan nyaman
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Pembelajaran yang didapat mahasiswa dalam persiapan pemeriksaan ANC meliputi **peningkatan pengetahuan, keterampilan praktik, penerapan patient safety, sikap profesional, serta kemampuan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil.**
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Refleksi patient safety dalam persiapan pemeriksaan ANC pada OBE bertujuan agar mahasiswa mampu **mengevaluasi tindakan yang dilakukan, memastikan keselamatan pasien, serta meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan antenatal**

Komponen	Deskripsi	Contoh Persiapan Pemeriksaan ANC: Alat, Lingkungan, Privasi dan Pencegahan Infeksi
		sesuai standar praktik kesehatan

E. Rangkuman Materi

Persiapan pemeriksaan ANC yang meliputi alat, lingkungan, privasi, dan pencegahan infeksi merupakan bagian penting dalam pelayanan antenatal yang berkualitas. Persiapan yang baik mendukung keselamatan pasien (*patient safety*), mencegah infeksi, menjaga kenyamanan dan privasi ibu hamil, serta meningkatkan akurasi hasil pemeriksaan dan mutu pelayanan kebidanan. Misalnya, pemeriksaan kelengkapan dan fungsi alat sebelum digunakan dapat mencegah kesalahan pengukuran tekanan darah, berat badan, atau denyut jantung janin. Verifikasi identitas pasien sebelum pemeriksaan juga penting untuk memastikan bahwa tindakan dilakukan pada pasien yang tepat. Selain itu, lingkungan yang aman dan tertata dapat mengurangi risiko kecelakaan seperti terpeleset atau terjatuh, terutama pada ibu hamil dengan mobilitas terbatas.

Persiapan yang baik mencakup penerapan kebersihan tangan sesuai standar WHO, penggunaan alat pelindung diri (APD) sesuai kebutuhan, serta pembersihan dan desinfeksi alat maupun permukaan yang digunakan untuk pemeriksaan. Selain itu, pengelolaan limbah medis yang benar juga membantu mencegah penyebaran mikroorganisme penyebab penyakit.

Privasi juga merupakan hak pasien yang harus dihormati. Menutup pintu atau tirai saat pemeriksaan, membatasi akses orang yang tidak berkepentingan, dan menjaga kerahasiaan informasi kesehatan merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat dan hak pasien.

Selain itu, penerapan komunikasi efektif, empati, dan informed consent mencerminkan pelayanan yang berpusat pada perempuan (*woman-centered care*) dan sesuai dengan prinsip Respectful Maternity Care (RMC). Penerapan komunikasi efektif, empati, dan informed consent merupakan bagian penting dalam pelayanan kebidanan yang berpusat pada perempuan (woman-centered care) dan sejalan dengan prinsip Respectful Maternity Care (RMC)**.**

F. Tabel Red Flags & Eskalasi

Persiapan Pemeriksaan ANC: Alat, Lingkungan, Privasi dan Pencegahan Infeksi

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Persiapan alat yang tidak lengkap	Adanya indikasi bahwa proses pemeriksaan atau tindakan medis **berpotensi tidak dilakukan secara optimal, tidak akurat, dan dapat meningkatkan risiko terhadap keselamatan pasien.**	Tindakan eskalasi pada persiapan alat yang tidak lengkap meliputi **melengkapi alat, melaporkan kepada pembimbing, mengganti alat yang rusak, menunda pemeriksaan jika perlu, serta melakukan**

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
		koordinasi dengan tim kesehatan untuk memastikan keselamatan pasien dan kelancaran pemeriksaan ANC.
Lingkungan yang tidak nyaman	Makna klinis dari lingkungan yang tidak nyaman pada persiapan pemeriksaan ANC adalah **indikasi adanya faktor yang dapat mengganggu kenyamanan pasien, mempengaruhi keakuratan pemeriksaan, meningkatkan risiko infeksi, dan menurunkan kualitas pelayanan kesehatan.**	Tindakan eskalasi pada lingkungan yang tidak nyaman meliputi membersihkan dan menata ruangan, memperbaiki kondisi lingkungan, menjaga privasi pasien, memindahkan tempat pemeriksaan jika diperlukan, serta melaporkan masalah kepada petugas yang bertanggung jawab agar pemeriksaan ANC dapat berlangsung aman dan nyaman.
Tidak Menjaga Privacy pasien	Adanya **risiko ketidaknyamanan psikologis, menurunnya kepercayaan pasien, gangguan dalam proses pemeriksaan, serta pelanggaran terhadap etika dan standar pelayanan kesehatan.**	**Menutup tirai atau pintu, menutup bagian tubuh pasien, membatasi orang di ruangan, memindahkan tempat pemeriksaan jika perlu, serta melaporkan kepada petugas yang bertanggung jawab** agar privasi dan kenyamanan pasien tetap terjaga
Tidak melakukan pencegahan infeksi	Adanya **risiko penularan penyakit, bahaya bagi pasien dan tenaga kesehatan, serta penurunan kualitas dan keamanan pelayanan kesehatan**, sehingga prinsip pencegahan infeksi harus selalu diterapkan dalam setiap tindakan medis	**Segera melakukan cuci tangan, menggunakan APD, mengganti alat dengan yang bersih atau steril, membersihkan lingkungan, serta melaporkan kepada tenaga kesehatan yang bertanggung jawab** untuk menjaga keselamatan pasien dan tenaga kesehatan.

G. Daftar Pustaka

Aliah, N., Hakim, R. I., Sumarni, Warini, Nasution, F., Nasution, N., Haryono, I. A., Zannah, A. N., & Martini. (2025). Buku Antenatal Care dalam Praktik Kebidanan. Mahakarya Citra Utama Group.

Gustini. (2025). Keperawatan Maternitas Antenatal Care (ANC). Get Press Indonesia.

Isyti'aroh, Rofiqoh, S., Widyastuti, W., & Aktifah, N. (2024). Buku Ajar Keperawatan Maternitas: Antenatal Care. Penerbit NEM.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman pelayanan antenatal terpadu (Edisi III). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. ISBN 978-602-416-974-9

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) Edisi Revisi. Kementerian Kesehatan RI.

Munthe, J., Simbolon, L., Marlina, Adethia, K., & Damanik, L. P. U. (2022). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Berkesinambungan: Continuity of Care (Edisi 2). Trans Info Media.

Perry, S. E., Cashion, K., Alden, K. R., Olshansky, E., & Hockenberry, M. J. (2023). Maternal Child Nursing Care (7th ed.). Elsevier

BAB 3

PEMERIKSAAN FISIK UMUM: KEPALA–LEHER, JANTUNG–PARU, ABDOMEN NON-OBSTETRI, DAN EKSTREMITAS

A. Teori Dasar

Pemeriksaan antenatal merupakan bagian esensial dalam pelayanan kesehatan ibu yang bertujuan memastikan kondisi ibu dan janin berada dalam keadaan optimal selama kehamilan. Dalam pendekatan modern, antenatal care tidak hanya berfokus pada aspek obstetri, tetapi juga mencakup penilaian kesehatan umum ibu melalui pemeriksaan fisik sistemik. Menurut WHO, pelayanan antenatal yang berkualitas harus mencakup minimal delapan kontak ANC selama kehamilan, pemeriksaan fisik yang komprehensif, skrining faktor risiko, konseling kesehatan, serta deteksi dini komplikasi untuk meningkatkan pengalaman kehamilan yang positif dan menurunkan morbiditas maternal-neonatal (WHO, 2016; NICE, 2025).

Pemeriksaan fisik umum pada ibu hamil meliputi evaluasi kepala–leher, sistem kardiovaskular, sistem respirasi, abdomen non-obstetri, serta ekstremitas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi patologis yang mungkin tidak secara langsung berkaitan dengan kehamilan, namun memiliki dampak signifikan terhadap keselamatan ibu dan janin, seperti anemia, penyakit jantung, gangguan respirasi, dan preeklamsia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kelengkapan pemeriksaan fisik merupakan determinan utama kualitas antenatal care dan berkontribusi pada deteksi dini komplikasi (Arsenault et al., 2024; Kataria et al., 2025). Secara fisiologis, kehamilan menyebabkan berbagai perubahan sistem tubuh yang kompleks. Terjadi peningkatan volume darah hingga 30–50%, peningkatan curah jantung, serta penurunan resistensi vaskular sistemik yang berdampak pada perubahan hemodinamik. Selain itu, kebutuhan oksigen meningkat akibat peningkatan metabolisme basal, sehingga sistem respirasi mengalami adaptasi berupa peningkatan ventilasi. Perubahan hormonal, terutama peningkatan progesteron dan estrogen, juga mempengaruhi berbagai organ tubuh termasuk sistem kardiovaskular, respirasi, dan muskuloskeletal. Oleh karena itu, interpretasi hasil pemeriksaan fisik pada ibu hamil harus mempertimbangkan

adaptasi fisiologis tersebut agar tidak terjadi overdiagnosis maupun underdiagnosis (Karrar et al., 2024). FIGO dan ACOG menegaskan bahwa evaluasi edema patologis, tekanan darah, refleks tendon dalam, serta tanda-tanda preeklamsia harus menjadi bagian rutin pemeriksaan fisik pada setiap kunjungan ANC karena berkontribusi terhadap deteksi dini hipertensi dalam kehamilan (FIGO, 2023; ACOG, 2024).

1. **Pemeriksaan Kepala dan Leher** merupakan langkah awal dalam evaluasi kondisi umum ibu hamil. Inspeksi konjungtiva penting untuk mendeteksi anemia, yang masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama pada kehamilan. Konjungtiva yang pucat mengindikasikan kemungkinan kadar hemoglobin rendah yang dapat berdampak pada suplai oksigen ke janin. Selain itu, pemeriksaan wajah dapat menunjukkan adanya edema yang berhubungan dengan preeklamsia. Pemeriksaan leher dilakukan untuk menilai pembesaran kelenjar tiroid atau limfa, yang dapat mengindikasikan gangguan endokrin atau infeksi sistemik.
2. **Pemeriksaan Sistem Kardiovaskular (Jantung)** meliputi inspeksi, palpasi, dan auskultasi untuk menilai bunyi jantung, irama, serta adanya murmur. Murmur fisiologis dapat ditemukan pada kehamilan akibat peningkatan volume darah, namun murmur patologis harus diwaspadai sebagai tanda penyakit jantung. Evaluasi denyut nadi juga penting untuk menilai status hemodinamik ibu. Deteksi dini gangguan kardiovaskular sangat penting karena kondisi ini dapat meningkatkan risiko komplikasi maternal dan perinatal.
3. **Pemeriksaan Sistem Respirasi (Paru)** dilakukan melalui inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi untuk menilai pola napas dan adanya suara tambahan seperti wheezing atau ronki. Gangguan respirasi pada ibu hamil dapat berdampak langsung pada oksigenasi janin, sehingga deteksi dini sangat penting dalam mencegah hipoksia fetal.
4. **Pemeriksaan Abdomen Non-Obstetri** penting untuk mengidentifikasi kondisi patologis lain seperti gangguan gastrointestinal, infeksi intraabdomen, atau massa abnormal. Pemeriksaan meliputi inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Bidan harus mampu membedakan antara keluhan yang berasal dari kehamilan dengan kondisi non-obstetri agar tidak terjadi kesalahan diagnosis.
5. **Pemeriksaan Ekstremitas** bertujuan menilai adanya edema, varises, atau gangguan sirkulasi perifer. Edema fisiologis sering ditemukan pada kehamilan trimester akhir, namun edema yang disertai hipertensi dapat menjadi tanda preeklamsia. Pemeriksaan capillary refill time (CRT) juga dapat digunakan

untuk menilai perfusi perifer. Selain itu, refleks tendon dalam dapat diperiksa untuk mendeteksi hiperrefleksia yang berkaitan dengan preeklamsia berat.

Dalam praktik kebidanan, ketidaklengkapan pemeriksaan fisik umum masih menjadi tantangan yang dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis dan meningkatkan risiko komplikasi. Studi terbaru menunjukkan bahwa kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar pemeriksaan antenatal terpadu berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan dan keselamatan pasien (Yuliyanti et al., 2024). Dengan demikian, pemeriksaan fisik umum merupakan bagian integral dari *antenatal care* berbasis *evidence-based practice* dan menjadi kompetensi inti yang harus dikuasai oleh mahasiswa kebidanan dalam kerangka *Outcome-Based Education* (OBE). Dalam pendekatan OBE, mahasiswa tidak hanya dituntut memahami konsep, tetapi juga mampu melakukan pemeriksaan secara sistematis, menginterpretasikan temuan klinis secara tepat, serta mengambil keputusan klinis yang berorientasi pada keselamatan ibu dan janin.

B. Defenisi

Pemeriksaan antenatal merupakan bagian esensial dalam pelayanan kesehatan ibu yang bertujuan memastikan kondisi ibu dan janin berada dalam keadaan optimal selama kehamilan. Dalam pendekatan modern, antenatal care tidak hanya berfokus pada aspek obstetri, tetapi juga mencakup penilaian kesehatan umum ibu melalui pemeriksaan fisik sistemik. Organisasi kesehatan global menegaskan bahwa pelayanan antenatal yang berkualitas harus mencakup integrasi anamnesis, pemeriksaan fisik, serta skrining risiko untuk meningkatkan luaran maternal dan neonatal (World Health Organization, 2022; 2025). Pendekatan ini sejalan dengan konsep **continuum of care** dan **quality of care framework**, yang menempatkan deteksi dini risiko sebagai komponen utama dalam pencegahan komplikasi kehamilan.

Pemeriksaan fisik umum pada ibu hamil meliputi evaluasi kepala–leher, sistem kardiovaskular, sistem respirasi, abdomen non-obstetri, serta ekstremitas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi patologis yang mungkin tidak secara langsung berkaitan dengan kehamilan, namun memiliki dampak signifikan terhadap keselamatan ibu dan janin, seperti anemia, penyakit jantung, gangguan respirasi, dan preeklamsia. Bukti ilmiah terbaru menunjukkan bahwa kelengkapan pemeriksaan fisik merupakan determinan utama kualitas antenatal care dan berkontribusi signifikan terhadap deteksi dini komplikasi serta penurunan morbiditas maternal (Arsenault et al., 2024; Kataria et al., 2025).

Secara konseptual, pemeriksaan fisik umum dalam antenatal care merupakan bagian dari pendekatan **holistik dan woman-centered care**, dimana ibu hamil

dipandang sebagai individu dengan kondisi biopsikososial yang saling berinteraksi. Pendekatan ini menekankan bahwa kesehatan ibu tidak dapat dipisahkan dari kondisi sistemik yang mendasarinya, sehingga deteksi dini penyakit non-obstetri menjadi krusial dalam mencegah morbiditas dan mortalitas maternal. Studi terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar komplikasi kehamilan berkaitan dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya atau berkembang selama kehamilan, sehingga pemeriksaan fisik sistemik menjadi komponen penting dalam skrining risiko komprehensif (Karrar et al., 2024).

Selain itu, kehamilan memicu berbagai perubahan fisiologis yang kompleks, termasuk peningkatan volume plasma hingga 40–50%, peningkatan curah jantung, serta adaptasi sistem respirasi berupa peningkatan ventilasi. Perubahan hormonal, terutama peningkatan progesteron dan estrogen, turut memengaruhi fungsi berbagai sistem tubuh. Oleh karena itu, interpretasi hasil pemeriksaan fisik harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan perbedaan antara kondisi fisiologis dan patologis. Kesalahan dalam interpretasi dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis atau intervensi yang tidak tepat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan.

Dalam konteks kualitas pelayanan, kelengkapan dan ketepatan pemeriksaan fisik umum merupakan indikator penting dalam standar pelayanan antenatal terpadu. Evidence terkini menunjukkan bahwa kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar pemeriksaan klinis, termasuk pemeriksaan fisik sistemik, berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien (Yuliyanti et al., 2024). Hal ini menegaskan bahwa pemeriksaan fisik tidak hanya berfungsi sebagai alat diagnostik, tetapi juga sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu (quality assurance) dalam pelayanan kesehatan ibu.

Dengan demikian, pemeriksaan fisik umum dalam antenatal care merupakan proses klinis yang sistematis, komprehensif, dan berbasis evidence-based practice yang berperan penting dalam deteksi dini kondisi patologis, pemantauan adaptasi fisiologis kehamilan, serta pengambilan keputusan klinis yang tepat guna meningkatkan keselamatan ibu dan janin.

C. Tujuan

1. Mengidentifikasi kondisi kesehatan umum ibu hamil secara komprehensif sebagai dasar penilaian klinis.
2. Mendeteksi dini kelainan sistemik yang berpotensi mempengaruhi kehamilan dan luaran maternal dan neonatal.
3. Menilai adaptasi fisiologis tubuh selama kehamilan untuk membedakan kondisi normal dan patologis.

4. Mendukung penegakan diagnosis kebidanan secara holistik dan berbasis *evidence-based practice*.
5. Menentukan kebutuhan pemeriksaan lanjutan, intervensi, atau rujukan secara tepat waktu.

D. Indikasi

1. Semua kunjungan antenatal (trimester I–III).
2. Ibu hamil dengan keluhan sistemik (lemah, sesak, edema).
3. Riwayat penyakit kronis (hipertensi, jantung, anemia).
4. Kecurigaan komplikasi kehamilan.
5. Kehamilan risiko tinggi.

E. KontraIndikasi

1. Kondisi gawat darurat (syok, distress respirasi).
2. Nyeri hebat pada area tertentu.
3. Risiko infeksi tanpa APD.

F. Alat

1. Stetoskop
2. Tensimeter
3. Termometer
4. Penlight
5. Jam dengan detik
6. Sarung tangan
7. Refleks hammer (opsional)
8. Timbangan dan alat ukur tinggi badan
9. Formulir rekam medis

G. Persiapan

Persiapan dalam pemeriksaan fisik umum pada *antenatal care* merupakan tahap krusial yang menentukan kualitas hasil pemeriksaan serta keselamatan pasien. Dalam pendekatan pelayanan kesehatan berbasis *evidence*, persiapan yang adekuat mencerminkan penerapan prinsip *quality of care*, *patient safety*, dan *woman-centered care*, dimana setiap tindakan klinis harus dilakukan secara sistematis, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien (World Health Organization, 2022; 2025).

1. Persiapan Pasien

Persiapan pasien merupakan bagian dari pendekatan *patient-centered care* yang menempatkan ibu hamil sebagai subjek utama dalam pelayanan kesehatan.

a. Pemberian penjelasan prosedur dan informed consent. Tenaga kesehatan wajib memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan, prosedur, manfaat, dan kemungkinan ketidaknyamanan selama pemeriksaan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif pasien serta mengurangi kecemasan (Karrar et al., 2024).
b. Menjaga kenyamanan dan privasi pasien. Privasi merupakan aspek penting dalam pelayanan kebidanan karena berhubungan dengan martabat dan keamanan psikologis pasien, sehingga lingkungan yang nyaman dan aman akan meningkatkan kualitas interaksi klinis dan kepuasan pasien (World Health Organization, 2022).
c. Pengaturan posisi sesuai kebutuhan pemeriksaan. Posisi pasien harus disesuaikan dengan jenis pemeriksaan untuk memastikan akurasi hasil serta mencegah ketidaknyamanan, seperti sindrom hipotensi supinasi pada kehamilan trimester lanjut (Karrar et al., 2024).

2. Persiapan Petugas (Bidan)

Persiapan petugas mencerminkan profesionalisme dan kompetensi klinis dalam pelayanan kebidanan berbasis OBE.

a. Melakukan hand hygiene sesuai standar. Kebersihan tangan merupakan intervensi utama dalam pencegahan infeksi nosokomial dan terbukti efektif dalam menurunkan risiko transmisi mikroorganisme di fasilitas pelayanan kesehatan (World Health Organization, 2023).
b. Menggunakan alat pelindung diri (APD). Penggunaan APD bertujuan melindungi pasien dan tenaga kesehatan dari risiko infeksi silang, terutama pada kondisi dengan potensi paparan cairan tubuh (World Health Organization, 2022).
c. Memahami prosedur pemeriksaan secara sistematis. Pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur akan meningkatkan akurasi diagnosis serta efektivitas pengambilan keputusan klinis dalam antenatal care (Arsenault et al., 2024; Kataria et al., 2025).

3. Persiapan Lingkungan

Lingkungan pemeriksaan merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang mendukung kualitas asuhan kebidanan.

a. Ruangan nyaman, bersih, dan cukup terang. Lingkungan yang bersih dan pencahayaan yang memadai diperlukan untuk mendukung ketepatan inspeksi klinis serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien (World Health Organization, 2022).
b. Menjamin privasi pasien. Penggunaan tirai atau ruang tertutup merupakan bagian dari standar pelayanan kebidanan untuk menjaga kerahasiaan dan kenyamanan ibu selama pemeriksaan (Kementerian Kesehatan RI, 2021).
c. Ketersediaan alat yang lengkap dan siap pakai. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan indikator penting dalam kualitas pelayanan antenatal dan berpengaruh terhadap efektivitas pemeriksaan klinis (Kataria et al., 2025).

H. Langkah/Tindakan

Pemeriksaan fisik umum pada antenatal care dilakukan secara sistematis dan berurutan untuk memastikan seluruh sistem tubuh ibu hamil dievaluasi secara komprehensif. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi temuan klinis serta mendukung deteksi dini kondisi patologis yang dapat mempengaruhi kehamilan dan luaran maternal–neonatal (Arsenault et al., 2024).

1. Pemeriksaan Kepala–Leher

Pemeriksaan kepala dan leher merupakan langkah awal dalam menilai kondisi umum ibu hamil, khususnya untuk mendeteksi tanda-tanda anemia, preeklamsia, serta gangguan sistemik lainnya.

a. Inspeksi wajah (pucat, edema). Wajah diamati untuk mendeteksi pucat sebagai indikator anemia serta edema yang dapat mengarah pada preeklamsia, terutama jika disertai hipertensi (Karrar et al., 2024).
b. Pemeriksaan konjungtiva dan sklera. Konjungtiva diperiksa untuk menilai status hemoglobin secara klinis, sedangkan sklera diamati untuk mendeteksi ikterus yang dapat mengindikasikan gangguan hepatobilier (World Health Organization, 2022).
c. Pemeriksaan mulut. Evaluasi rongga mulut bertujuan menilai kebersihan, status nutrisi, serta adanya lesi atau infeksi yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu secara umum (Kataria et al., 2025).
d. Palpasi kelenjar tiroid. Pemeriksaan tiroid penting untuk mendeteksi pembesaran kelenjar yang dapat berhubungan dengan gangguan hormonal dan metabolik selama kehamilan (Karrar et al., 2024).

2. Pemeriksaan Jantung (Sistem Kardiovaskular)

Kehamilan menyebabkan perubahan fisiologis pada sistem kardiovaskular sehingga pemeriksaan jantung menjadi penting untuk membedakan kondisi normal dan patologis.

a. Inspeksi dan palpasi dada. Dilakukan untuk menilai adanya deformitas atau kelainan struktur serta menentukan lokasi ictus cordis (Karrar et al., 2024).
b. Auskultasi bunyi jantung. Bunyi jantung (S1, S2) dinilai untuk mengidentifikasi adanya murmur fisiologis maupun patologis yang dapat mengindikasikan penyakit jantung (Arsenault et al., 2024).
c. Evaluasi nadi. Penilaian frekuensi, irama, dan kekuatan nadi memberikan informasi tentang status hemodinamik ibu (World Health Organization, 2022).

3. Pemeriksaan Paru (Sistem Respirasi)

Adaptasi respirasi selama kehamilan memerlukan evaluasi yang cermat untuk memastikan oksigenasi ibu dan janin tetap optimal.

a. Inspeksi pola napas. Dilakukan untuk menilai frekuensi dan pola napas serta penggunaan otot bantu pernapasan (Karrar et al., 2024).
b. Palpasi ekspansi dada. Bertujuan menilai kesimetrisan ekspansi paru selama inspirasi (Kataria et al., 2025).
c. Perkusi dan auskultasi paru. Digunakan untuk mendeteksi adanya kelainan seperti konsolidasi, efusi, atau suara napas tambahan (ronki, wheezing) yang dapat mengindikasikan gangguan respirasi (World Health Organization, 2022).

4. Pemeriksaan Abdomen Non-Obstetri

Pemeriksaan abdomen non-obstetri penting untuk mengidentifikasi kondisi patologis di luar kehamilan yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu.

a. Inspeksi abdomen. Dilakukan untuk menilai distensi, bekas luka, atau kelainan bentuk abdomen (Karrar et al., 2024).
b. Auskultasi bising usus. Bertujuan menilai aktivitas gastrointestinal yang dapat berubah selama kehamilan (Kataria et al., 2025).
c. Palpasi abdomen. Dilakukan untuk mendeteksi nyeri tekan, massa, atau pembesaran organ (Arsenault et al., 2024).
d. Perkusi abdomen. Digunakan untuk menilai batas organ dan adanya cairan atau massa abnormal (World Health Organization, 2022).

5. Pemeriksaan Ekstremitas

Pemeriksaan ekstremitas dilakukan untuk menilai sirkulasi perifer dan mendeteksi tanda komplikasi seperti preeklamsia.

a. Inspeksi edema. Edema dinilai pada ekstremitas bawah, terutama jika bersifat patologis (disertai hipertensi atau proteinuria) (Karrar et al., 2024).
b. Palpasi ekstremitas. Bertujuan menilai suhu, nyeri tekan, dan konsistensi jaringan (Kataria et al., 2025).
c. *Capillary refill time* (CRT). Digunakan untuk menilai perfusi perifer, dimana CRT > 2 detik dapat mengindikasikan gangguan sirkulasi (World Health Organization, 2022).
d. Pemeriksaan refleks (opsional). Refleks tendon dalam diperiksa untuk mendeteksi hiperrefleksia yang berkaitan dengan preeklamsia berat (Arsenault et al., 2024).

I. Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien dalam pemeriksaan fisik umum pada antenatal care merupakan prinsip fundamental dalam praktik kebidanan yang bertujuan mencegah terjadinya cedera, kesalahan tindakan, maupun risiko yang dapat membahayakan ibu dan janin. Dalam pendekatan pelayanan kesehatan modern, patient safety tidak hanya berfokus pada pencegahan kesalahan, tetapi juga mencakup penerapan sistem pelayanan yang aman, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien (World Health Organization, 2022; 2025).

1. Prinsip Non-Maleficence (Tidak Membahayakan Pasien)

Prinsip non-maleficence menekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan harus menghindari potensi bahaya terhadap pasien. Dalam pemeriksaan fisik, bidan harus memastikan bahwa prosedur dilakukan secara hati-hati, tidak menimbulkan nyeri berlebihan, serta mempertimbangkan kondisi fisiologis kehamilan untuk mencegah komplikasi (Karrar et al., 2024).

2. Menghindari Tindakan Berlebihan (Over-Intervention)

Pemeriksaan fisik harus dilakukan secara rasional dan sesuai indikasi klinis untuk menghindari tindakan yang tidak perlu. Over-intervention dapat meningkatkan ketidaknyamanan pasien serta berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi klinis. Evidence terbaru menekankan pentingnya pendekatan **evidence-based practice** dalam menentukan tindakan klinis yang tepat (Arsenault et al., 2024; Kataria et al., 2025).

3. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Penggunaan APD merupakan bagian penting dalam pencegahan infeksi silang antara tenaga kesehatan dan pasien. Standar WHO menekankan bahwa

penggunaan APD harus disesuaikan dengan risiko paparan, terutama dalam pemeriksaan yang melibatkan kontak langsung dengan pasien (World Health Organization, 2023).

4. Menjaga Privasi dan Kerahasiaan Pasien

Privasi merupakan hak dasar pasien yang harus dijaga selama proses pemeriksaan. Dalam praktik kebidanan, menjaga privasi tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis dan sosial yang dapat mempengaruhi kenyamanan pasien (World Health Organization, 2022).

5. Komunikasi Terapeutik

Komunikasi terapeutik merupakan bagian integral dari patient safety yang bertujuan membangun hubungan saling percaya antara tenaga kesehatan dan pasien. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan pemahaman pasien terhadap prosedur yang dilakukan serta mengurangi kecemasan selama pemeriksaan (Karrar et al., 2024).

6. Mengikuti Standar Prosedur Operasional (SOP)

Pelaksanaan pemeriksaan fisik harus sesuai dengan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan untuk menjamin konsistensi dan kualitas pelayanan. Kepatuhan terhadap SOP terbukti berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan serta penurunan risiko kesalahan klinis dalam antenatal care (Yuliyanti et al., 2024).

J. Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil pemeriksaan fisik umum pada antenatal care merupakan tahap kritis dalam proses klinis yang bertujuan untuk menginterpretasikan temuan pemeriksaan secara komprehensif dan menentukan langkah tindak lanjut yang tepat. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada identifikasi temuan klinis, tetapi juga pada integrasi data untuk mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis evidence (World Health Organization, 2022; 2025).

1. Identifikasi Kondisi Normal dan Abnormal

Langkah awal evaluasi adalah membedakan antara temuan fisiologis normal pada kehamilan dan kondisi patologis. Perubahan fisiologis seperti peningkatan denyut jantung ringan atau edema ringan pada trimester akhir dapat dianggap normal, namun harus dibedakan dari kondisi patologis melalui penilaian klinis yang cermat. Ketepatan dalam membedakan kondisi ini sangat penting untuk mencegah kesalahan diagnosis dan intervensi yang tidak tepat (Karrar et al., 2024).

2. Deteksi Tanda Risiko Klinis

Evaluasi hasil pemeriksaan fisik harus mampu mengidentifikasi tanda-tanda risiko yang dapat mengarah pada komplikasi kehamilan, antara lain:

a. Pucat → anemia. Pucat pada konjungtiva merupakan indikator klinis anemia yang dapat mempengaruhi suplai oksigen ke janin dan meningkatkan risiko komplikasi kehamilan (World Health Organization, 2022).
b. Edema disertai hipertensi → preeklamsia. Edema patologis yang disertai peningkatan tekanan darah merupakan tanda awal preeklamsia yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah komplikasi serius (Karrar et al., 2024).
c. Murmur → gangguan jantung. Murmur jantung yang tidak fisiologis dapat mengindikasikan kelainan kardiovaskular yang berpotensi memperburuk kondisi kehamilan (Arsenault et al., 2024).
d. Sesak napas → gangguan respirasi. Keluhan sesak napas yang tidak sesuai dengan perubahan fisiologis kehamilan dapat mengindikasikan gangguan respirasi yang memerlukan evaluasi lebih lanjut (Kataria et al., 2025).

Deteksi dini tanda risiko ini merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan komplikasi maternal dan neonatal.

3. Penentuan Tindak Lanjut atau Rujukan

Berdasarkan hasil evaluasi, bidan harus menentukan apakah kondisi ibu memerlukan observasi lanjutan, intervensi, atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Keputusan rujukan harus dilakukan secara tepat waktu untuk mencegah keterlambatan penanganan yang dapat meningkatkan risiko komplikasi (World Health Organization, 2025).

4. Integrasi dengan Anamnesis dan Pemeriksaan Penunjang

Evaluasi hasil pemeriksaan fisik tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan dengan data anamnesis serta pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium. Pendekatan ini dikenal sebagai clinical reasoning, dimana tenaga kesehatan menggabungkan berbagai sumber informasi untuk memperoleh diagnosis yang akurat dan komprehensif (Arsenault et al., 2024).

K. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pemeriksaan fisik umum pada antenatal care merupakan komponen penting dalam praktik kebidanan yang berfungsi sebagai bukti tertulis dari proses pelayanan, dasar komunikasi antar tenaga kesehatan, serta bagian dari sistem penjaminan mutu dan keselamatan pasien. Dokumentasi yang lengkap, akurat, dan sistematis memungkinkan kesinambungan asuhan serta mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat (World Health Organization, 2022; 2025).

1. Identitas Pasien

Pencatatan identitas pasien meliputi nama, umur, gravida, usia kehamilan, serta nomor rekam medis. Identitas yang jelas sangat penting untuk memastikan ketepatan pelayanan dan mencegah kesalahan identifikasi pasien dalam proses klinis (World Health Organization, 2022).

2. Tanggal dan Waktu Pemeriksaan

Pencatatan tanggal dan waktu pemeriksaan diperlukan untuk memantau perkembangan kondisi ibu secara longitudinal selama kehamilan. Informasi ini juga penting dalam evaluasi efektivitas intervensi dan penentuan tindak lanjut (Karrar et al., 2024).

3. Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan fisik harus dicatat secara lengkap dan sistematis meliputi seluruh sistem tubuh yang diperiksa, seperti kepala–leher, jantung, paru, abdomen, dan ekstremitas. Pencatatan yang rinci akan meningkatkan akurasi interpretasi klinis dan memudahkan komunikasi antar tenaga kesehatan (Arsenault et al., 2024).

4. Interpretasi Klinis

Interpretasi klinis merupakan hasil analisis dari data pemeriksaan yang dikaitkan dengan kondisi fisiologis dan patologis kehamilan. Tahap ini mencerminkan kemampuan clinical reasoning tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi masalah atau potensi risiko yang dialami ibu hamil (Kataria et al., 2025).

5. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut mencakup keputusan klinis yang diambil berdasarkan hasil pemeriksaan, seperti observasi lanjutan, pemberian terapi, edukasi, atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Penentuan tindak lanjut yang tepat waktu merupakan bagian penting dalam pencegahan komplikasi maternal dan neonatal (World Health Organization, 2025).

L. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Contoh: Seorang perempuan usia 30 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 34 minggu, datang ke puskesmas untuk pemeriksaan antenatal rutin. Ibu mengeluh sering merasa pusing, cepat lelah, dan sejak 1 minggu terakhir mengalami bengkak pada kedua kaki.

Hasil anamnesis:

1. Tidak ada riwayat penyakit jantung sebelumnya
2. Riwayat kehamilan sebelumnya normal
3. Pola makan kurang teratur

Hasil pemeriksaan fisik:

1. Keadaan umum: tampak lemah
2. TD: 150/95 mmHg
3. Nadi: 96 x/menit
4. RR: 22 x/menit
5. Suhu: 36,8°C

Pemeriksaan sistemik:

1. Kepala–leher: konjungtiva pucat, wajah tampak edema
2. Jantung: bunyi jantung reguler, tidak ada murmur
3. Paru: suara napas vesikuler normal
4. Abdomen non-obstetri: tidak ada nyeri tekan
5. Ekstremitas: edema pitting (+) pada kedua kaki

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?
2. Data subjektif dan objektif apa saja yang mendukung analisis Anda?
3. Apakah temuan pemeriksaan fisik termasuk kondisi fisiologis atau patologis? Jelaskan alasan Anda.
4. Apa kemungkinan diagnosis atau masalah kebidanan pada kasus ini?
5. Temuan pemeriksaan fisik apa saja yang menjadi red flag (tanda bahaya)?
6. Pemeriksaan lanjutan apa yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis?
7. Bagaimana interpretasi hubungan antara hasil pemeriksaan fisik dengan kondisi kehamilan ibu?
8. Apa tindakan awal yang harus dilakukan oleh bidan pada kasus ini?
9. Apakah kasus ini memerlukan rujukan? Jelaskan indikasi rujukan berdasarkan kondisi pasien.
10. Bagaimana edukasi (KIE) yang tepat diberikan kepada ibu dan keluarga?

TEMPLATE SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Pemeriksaan Fisik Umum pada Ibu Hamil dengan Kecurigaan Preeklamsia
3	Kasus	Pemeriksaan fisik umum antenatal pada ibu hamil trimester III dengan keluhan pusing, lemah, dan edema
4	Tujuan	Untuk menilai kemampuan peserta dalam menunjukkan kompetensi sebagai calon bidan profesional dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan, usia 30 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 34 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan pusing, cepat lelah, dan bengkak pada kedua kaki sejak 1 minggu terakhir. Hasil pemeriksaan: TD 150/95 mmHg, N 96 x/menit, RR 22 x/menit, S 36,8°C Konjungtiva pucat, wajah edema, ekstremitas edema pitting (+) TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik umum secara sistematis. 3. Sampaikan hasil pemeriksaan dan interpretasi klinis. 4. Tentukan diagnosis/masalah kebidanan. 5. Lakukan tindakan awal yang tepat. 6. Berikan KIE kepada ibu/keluarga. 7. Tentukan kebutuhan rujukan.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Amati peserta tanpa interupsi

No.	Komponen	Isi
		2. Gunakan checklist penilaian 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan pemerilksaan fisik, penguji memberikan data: • TD: 150/95 mmHg • Konjungtiva pucat • Edema pitting (+) • Bunyi jantung normal • Paru normal Jika peserta meminta: • Hb → 9 g/dL • Urine protein → (+) INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 5. PS berperan sebagai ibu hamil. 6. PS tampak cemas, lemah, mengeluh pusing, kaki bengkak.

No.	Komponen	Isi
		7. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 8. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Apa keluhan utama Ibu? PS: Saya pusing dan kaki saya bengkak Bu. Peserta: Sejak kapan? PS: Sekitar satu minggu ini Peserta: Apakah mudah lelah? PS: Iya, cepat capek. Peserta: Apakah ibu punya riwayat penyakit? PS: Tidak ada. Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	- Manikin auskultasi jantung-paru - Manikin pemeriksaan refleks
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold — 1 3. Phantom panggul/serviks — 1 4. Lembar partograf kasus — 1 set 5. Tensimeter — 1 6. Stetoskop — 1 7. Doppler/Pinard — 1 8. Jam tangan/stopwatch — 1 9. Termometer — 1

No.	Komponen	Isi
		10. Sarung tangan bersih — 1 pasang 11. Handrub — 1 botol 12. Kain penutup/selimut — 1 13. Tisu — 1 pack 14. Infus set dummy — 1 set 15. Cairan RL/NaCl dummy — 1 16. Abocath dummy — 1 17. Formulir rujukan — 1 lembar 18. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 19. Pena — 1
13	Penulis	Dr. Bd. Ika Nur Saputri, S. ST., M.Keb
14	Referensi	1. World Health Organization. (2022). *WHO antenatal care recommendations for a positive pregnancy experience*. Geneva: WHO. 2. World Health Organization. (2023). *Simulation-based education for health workforce training: Global standards*. Geneva: WHO. 3. International Confederation of Midwives (ICM). (2021). *Global standards for midwifery education*.

M. Tabel Red Flags & Eskalasi

Pemeriksaan Fisik Umum pada Ibu Hamil dengan Kecurigaan Preeklamsia

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Tekanan darah ≥ 140/90 mmHg	Indikasi hipertensi dalam kehamilan yang dapat berkembang menjadi preeklamsia	Monitoring tekanan darah, evaluasi lanjutan, dan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi
Edema patologis (wajah/tangan/kaki disertai hipertensi)	Tanda awal preeklamsia akibat gangguan permeabilitas kapiler	Observasi ketat, pemeriksaan protein urin, dan rujukan segera
Konjungtiva pucat	Indikasi anemia yang dapat menurunkan suplai oksigen ke janin	Pemeriksaan Hb, terapi anemia, dan monitoring kondisi ibu
Proteinuria (+)	Penanda utama preeklamsia yang menunjukkan keterlibatan ginjal	Konfirmasi diagnosis preeklamsia dan rujukan untuk penanganan lanjut
Nyeri kepala berat	Tanda gangguan perfusi serebral pada preeklamsia berat	Rujukan segera untuk mencegah komplikasi neurologis
Gangguan penglihatan (kabur, fotopsia)	anda preeklamsia berat yang berisiko eklampsia	Rujukan emergensi
Nyeri epigastrium	Indikasi keterlibatan hati (preeklamsia berat/HELLP syndrome)	Rujukan segera ke fasilitas rujukan
Sesak napas	Kemungkinan edema paru akibat preeklamsia berat	Stabilkan pasien dan rujukan emergensi
Refleks hiperaktif	Tanda iritabilitas neuromuskular pada preeklamsia berat	Observasi ketat dan rujukan
Penurunan kesadaran/kejang	Eklampsia (komplikasi berat preeklamsia)	Penanganan kegawatdaruratan dan rujukan segera

N. Rangkuman Materi

Pemeriksaan fisik umum pada antenatal care merupakan komponen esensial dalam deteksi dini risiko kehamilan yang tidak hanya mendukung diagnosis, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan klinis yang tepat. Integrasi pemeriksaan fisik dengan anamnesis dan skrining risiko akan meningkatkan kualitas pelayanan serta keselamatan maternal dan neonatal. Literatur terbaru menegaskan bahwa peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pemeriksaan fisik akan meningkatkan kualitas antenatal care dan outcome kehamilan secara signifikan (Kataria et al., 2025; Wahyuningsih et al., 2025).

Persiapan dalam pemeriksaan fisik umum bukan hanya tahap awal prosedur, tetapi merupakan bagian integral dari clinical governance dan patient safety dalam antenatal care. Persiapan yang optimal akan meningkatkan kualitas pemeriksaan, akurasi diagnosis, serta keselamatan ibu dan janin. Dalam kerangka *Outcome-Based Education* (OBE), kemampuan melakukan persiapan yang tepat mencerminkan kompetensi profesional mahasiswa dalam praktik kebidanan berbasis evidence. Persiapan dalam pemeriksaan fisik umum merupakan bagian integral dari praktik antenatal care berbasis evidence yang tidak hanya mempengaruhi kualitas pemeriksaan, tetapi juga keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan ibu secara keseluruhan (Arsenault et al., 2024; World Health Organization, 2025).

Langkah tindakan pemeriksaan fisik umum pada antenatal care harus dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan berbasis evidence untuk memastikan deteksi dini kondisi patologis serta mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat. Pendekatan ini merupakan bagian integral dari pelayanan kebidanan berkualitas yang berorientasi pada keselamatan ibu dan janin (World Health Organization, 2025).

Penerapan prinsip patient safety dalam pemeriksaan fisik umum merupakan bagian integral dari pelayanan antenatal yang berkualitas. Integrasi antara prinsip non-maleficence, komunikasi terapeutik, penggunaan APD, serta kepatuhan terhadap standar prosedur akan meningkatkan keselamatan ibu dan janin serta mutu pelayanan kebidanan secara keseluruhan (World Health Organization, 2025).

Evaluasi hasil pemeriksaan fisik umum merupakan proses analitis yang memerlukan kemampuan berpikir kritis dan clinical reasoning. Ketepatan dalam mengidentifikasi kondisi normal dan abnormal, mendeteksi tanda risiko, serta menentukan tindak lanjut akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas antenatal care dan keselamatan ibu serta janin (World Health Organization, 2025).

Dokumentasi yang baik merupakan indikator kualitas pelayanan antenatal dan bagian integral dari patient safety. Integrasi pencatatan yang lengkap dengan interpretasi klinis dan rencana tindak lanjut akan meningkatkan kontinuitas asuhan, akurasi diagnosis, serta keselamatan ibu dan janin dalam pelayanan kebidanan berbasis evidence (Arsenault et al., 2024; World Health Organization, 2025).

O. Daftar Pustaka

American College of Obstetricians and Gynecologists. (2024). *Routine prenatal care*. ACOG Clinical Practice Guidelines. Washington, DC.

American College of Obstetricians and Gynecologists. (2024). *Screening and management of anemia in pregnancy*. ACOG Practice Bulletin.

Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., et al. (2022). *Williams Obstetrics* (26th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

International Confederation of Midwives. (2024). *Essential competencies for midwifery practice*. The Hague: ICM.

International Federation of Gynecology and Obstetrics. (2023). *FIGO good clinical practice advice: Management of hypertensive disorders in pregnancy*. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 161(Suppl. 1), 1–24.

Karrar, S. A., Aftab, Z., & Colleagues. (2025). *Initial antepartum care*. In *StatPearls*. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Standar Pelayanan Kebidanan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Edisi Revisi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu*. Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga.

National Institute for Health and Care Excellence. (2025). *Antenatal care (NICE Guideline NG201)*. London: NICE.

Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. (2023). *Pedoman Antenatal Care Berbasis Risiko*. Jakarta: POGI.

Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. (2023). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran: Hipertensi dalam Kehamilan*. Jakarta: POGI.

World Health Organization. (2016). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2022). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2024). *Improving maternal and newborn health and survival and reducing stillbirth: Progress report*. Geneva: WHO.

BAB 4

PEMERIKSAAN ABDOMEN OBSTETRI: LEOPOLD, TINGGI FUNDUS, PRESENTASI, DAN PENURUNAN BAGIAN TERENDAH

CPL

CPL-2	Mampu melaksanakan pemeriksaan antenatal terpadu secara sistematis, aman, dan efektif.	CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4
CPL-3	Mampu menginterpretasi temuan klinis dan penunjang untuk mengenali masalah serta risiko kehamilan.	CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6

CPMK

CPMK-4	Melaksanakan pemeriksaan abdomen obstetri dan penilaian kesejahteraan janin secara sistematis serta menginterpretasi hasil pemantauan klinis.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 6. Pemeriksaan Abdomen Obstetri: Leopold, Tinggi Fundus, Presentasi, dan Penurunan Bagian Terendah	6.1 Melakukan manuver Leopold, mengukur tinggi fundus, dan menilai presentasi/posisi janin.	6.2 Menilai penurunan bagian terendah dan kesesuaian usia kehamilan berbasis TFU.	CPMK-4	CPMK-3; CPMK-6

Uraian Materi

Pemeriksaan kehamilan secara rutin merupakan salah satu tindakan preventif dan sebagai deteksi dini adanya risiko masa kehamilan. Hasil interpretasi pemeriksaan palpasi abdomen menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan janin, disamping pemeriksaan penunjang yang lain. Tenaga kesehatan diharapkan kompeten dalam melakukan pemeriksaaan abdomen, yang meliputi : palpasi (Leopold), mengukur tinggi fundus uteri, identifikasi presentasi dan penurunan bagian terendah janin. WHO menjelaskan setiap kehamilan wajib dilakukan assessment guna mengidentifikasi faktor resiko masa kehamilan. Penatalaksanaan kehamilan didasarkan pada hasil anamnesa, dan assessment yang dilakukan dengan baik dan benar.

A. Palpasi Leopold

Palpasi Leopold atau disebut juga manuver leopold merupakan metode sistematis palpasi abdomen untuk menilai posisi, presentasi dan keterlibatan janin mulai pada trimester ketiga. Manuver ini menggunakan teknik non-invasif, berbiaya rendah dan bergantung pengalaman pemeriksa. Menggunakan empat palpasi yang berbeda dan bertujuan untuk mendeteksi malpresentasi yang dapat meningkatkan risiko, Berikut ini Langkah-langkah pemeriksaan palpasi Leopold 1 s.d 4.

1. Leopold I (Menentukan Tinggi Fundus dan bagian janin di fundus)

Tujuannya untuk mendeteksi tinggi fundus uteri dan bagian kutub janin mana yang ada di fundus. Ibu sebaiknya diminta mengosongkan kandung kemih sebelum pemeriksaan ini dimulai agar tidak mengaburkan hasil papasi. Posisi ibu supinasi, kaki ditekuk, kepala diganjal bantal setinggi kurang lebih 15 °, pemeriksa berada dilateral kanan ibu menghadap os xiphoid. Penentuan Tinggi Fundus Uteri dapat dilakukan dengan menggunakan alat pita sentimeter/metlin pada teknik Mc.Donald, atau menggunakan jari pemeriksa pada manuver Leopold . Pengukuran dengan pita sentimeter dimulai dari batas atas simphisis pubis hingga batas atas fundus di bagian tengah abdomen dengan rumus sebagai berikut:

a. Usia kehamilan (hitungan bulan) = Tingggi Fundus Uteri (dalam cm) X 2/7
b. Usia kehamilan (hitungan minggu) = Tingggi Fundus Uteri (dalam cm) X 8/.

Pada teknik Leopold dapat menggunakan jari-jari pemeriksa dalam menentukan tinggi fundus uteri, dengan interpretasi hasil sebagaimana yang tercantum pada gambar berikut:

Ukuran Tinggi Fundus Uteri

Usia Kehamilan (Minggu)	Tinggi Fundus Uteri (TFU)
12	3 jari diatas simpisis
16	Pertengahan pusat-simpisis
20	3 jari dibawah pusat
24	Sepusat
28	3 jari di bawah pusat
32	Pertengahan pusat-prosessus xipoideus
36	3 jari di bawah prosessus xipoideus
40	Pertengahan pusat-prosessus xipoideus

Tahap berikutnya menentukan bagian janin yang berada di fundus uteri. Meletakkan telapak tangan kanan dan kiri pada sisi fundus dengan jari-jari berdekatan, merabanya dengan lembut menggunakan ujung jari guna mengidentifikasi bagian janin mana yang terletak di fundus uteri. Interpretasi: Jika kepala, teraba bulat, keras dan dapat dilentingkan *(Ballotement)*, jika bokong teraba bentuk yang tidak spesifik, lebih besar dan lebih lunak dari kepala, sulit digerakkan dan fundus terasa penuh, ini merupakan temuan pada kehamilan dengan letak janin normal. Pada letak lintang, palpasi didaerah fundus terasa kosong.

2. Leopold 2 (Menentukan Posisi Punggung)

Tujuannya untuk menentukan posisi tulang belakang dan anggota tubuh janin, seperti kanan atau kiri, dan letak janin, seperti memanjang, melintang, atau miring. Manuver ini dilakukan sambil menghadap tulang rawan xiphoid ibu dengan tangan pemeriksa diletakkan rata di dinding perut. Pemeriksa menggeser kedua tangan ke bawah dari fundus uterus ke dinding lateral uterus hingga setinggi pusar. Saat pemeriksa memberikan tekanan lembut, punggung janin dan bagian-bagian kecilnya diraba oleh masing-masing tangan. Struktur yang keras dan tidak bergerak di sepanjang lengkungan lateral uterus merupakan ciri tulang belakang janin, sedangkan struktur kecil atau nodular teraba bergerak sesuai dengan anggota tubuh janin. Jantung janin juga dapat didengarkan pada saat ini, memberikan informasi tentang orientasi janin. Jantung lebih mudah didengar ketika stetoskop atau transduser Doppler diletakkan di punggung janin.

3. Leopold 3 (Menentukan Bagian Terbawah)

Bertujuan mengidentifikasi presentasi janin / menentukan bagian janin apa yang berada di bagian bawah rahim dan apakah bagian tersebut sudah "masuk" ke pintu atas panggul (PAP). Manuver ketiga, juga dikenal sebagai pegangan Pawlik, dimodifikasi oleh Karel Pawlík (1849–1914), Menggunakan satu tangan (biasanya tangan kanan) Ibu jari dan jari-jari lainnya meraba bagian bawah perut ibu tepat di atas simfisis pubis. Segmen uterus bagian bawah dan bagian janin yang presentasi dipegang menggunakan ibu jari dan jari-jari satu tangan di atas simfisis pubis. Pemeriksa kemudian memberikan tekanan lembut ke atas untuk memperkirakan keterlibatan bagian yang presentasi. Jika bagian yang diraba bergerak, bagian yang presentasi belum masuk dan sebaliknya.

4. Leopold IV (Menentukan Seberapa Jauh Masuk Panggul)

Tujuan utamanya adalah memastikan sejauh mana bagian terbawah janin telah masuk ke dalam pintu atas panggul (PAP), membantu mengidentifikasi presentasi janin. Segmen uterus bagian bawah dan bagian janin yang presentasi dipegang menggunakan ibu jari dan jari-jari satu tangan di atas simfisis pubis. Pemeriksa memberikan tekanan lembut ke atas untuk memperkirakan masuknya bagian yang presentasi. Jika bagian yang diraba dapat digerakkan, bagian yang presentasi belum masuk/*engaged* maka kedua jari tangan pemeriksa dapat dipertemukan dan disebut konvergen. Temuan ini di dapatkan pada ibu hamil primigravida di usia kehamilan kurang dari 36 minggu, dan multigravida. Jika bagian yang diraba sulit digerakkan, maka bagian presentasi sudah tercakup dalam pintu atas panggul dan disebut *engaged,* kedua jari pemeriksa sulit bertemu karena terhalang penurunan bagian terendah yang memasuki pintu atas panggul dan disebut divergen. Temuan ini lazim didapatkan pada primigravida dengan usia kehamilan lebih atau sama dengan 36 minggu, serta multigravida menjelang persalinan.

B. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Contoh:

Seorang perempuan, usia 23 tahun, G1P0A0, hamil 36 minggu, datang ke Puskesmas untuk kunjungan ulang pemeriksaan kehamilan. Hasil anamnesis: Tidak ada tanda bahaya kehamilan, gerak janin terakhir 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan: TD 120/80 mmHg, N 103 x/menit, P 24 x/menit, S 37,1°C, IMT 19, Kenaikan BB 11 Kg, L 1: Teraba bulat, keras dan mudah digerakkan serta fundus

terasa penuh, TFU 2 jari di bawah Prosessus xhipoideus, punggung kanan, DJJ 112 X/mnt, bagian presentasi teraba bagian kurang spesifik, lunak, sulit digerakkan, konvergen.

Pertanyaan Diskusi

1. Tentukan, apakah hasil pemeriksaan diatas normal atau patologis?
2. Data apa saja yang mendukung analisis Anda?
3. Informasi penting apa yang harus disampaikan bidan kepada ibu dan keluarga?

Template Soal OSCE Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Palpasi Abdomen (Leopold)
3	Kasus	Antenatal care pada kehamilan patologis
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. **Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana** 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. **Perilaku profesional**
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan, usia 23 tahun, G1P0A0, hamil 36 minggu, datang ke Puskesmas untuk kunjungan ulang pemeriksaan kehamilan. Hasil anamnesis: Tidak ada tanda bahaya kehamilan, gerak janin terakhir 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan: TD 120/80 mmHg, N 103 x/menit, P 24 x/menit, S 37,1°C, IMT 19, Kenaikan BB 11 Kg. TUGAS 1. Lakukan pemeriksaan palpasi abdomen pada kasus diatas. 2. Tuliskan interpretasi hasil pemeriksaan palpasi abdomen (Leopold)..
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut:

No.	Komponen	Isi
		a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan palpasi abdomen/Leopold, penguji memberikan data:- TFU 33 cm, teraba kepala, Punggung kiri- Presentasi bokong- di atas PAP 3. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 4. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 9. PS berperan sebagai ibu hamil usia kehamilan 36 minggu dengan letak sungsang 10. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu.

No.	Komponen	Isi
		Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Saya ingin kontrol kehamilan Peserta: Apakah ibu terasa gerakan janinnya? PS: Iya, terakhir satu jam yang lalu. Peserta: Apakah ada keluhan lain? PS: terasa penuh di atas ulu hati. Peserta: Ini kehamilan yang ke berapa? PS: Ini kehamilan pertama saya, Bu. Peserta: Ada riwayat darah tinggi, operasi, atau penyakit lain? PS: Tidak ada, Bu. Peserta: Saya akan melakukan pemeriksaan fisik ibu, PS: Iya, Bu.termasuk bagian perut ibu PS: Baik, silahkan Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	-Phantom abdomen hamil/manekin Leopold - Medical Record pasien -
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti lembar partograf/lembar instruksi bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold — 1 3. Doppler/Pinard — 1 4. Jam tangan/stopwatch — 1 5. Handrub — 1 botol 6. Kain penutup/selimut — 1 7. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 8. Pena — 1
13	Penulis	.....
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020.

No.	Komponen	Isi
		2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. 3. World Health Organization. (2016).WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience

C. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Ante natal care: Palpasi Abdomen menurut Leopold, penentuan Tinggi Fundus Uteri, presentasi janin, dan seberapa jauh penurunan bagian terbawah janin

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Prosedur pemeriksaan palpasi abdomen
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada Prosedur pemeriksaan palpasi abdomen portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan palpasi abdomen dan interpretasi hasinya dengan tepat.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa menunjukkan peningkatan kemajuan belajar pada kepekaan perabaan terhadap bagian-bagian janin dari masukan CI dan dosen sehingga memiliki kemampuan dan ketepatan dalam menginterpretasikan hasil

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Prosedur pemeriksaan palpasi abdomen
		pemeriksaan palpasi abdomen pada ibu hamil.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan interpretasi hasil pemeriksaan palpasi abdomen. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan pemeriksaan palpasi abdomen dan menginterpretasikannya.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus ibu usia 23 tahun, G1P0A0, hamil 36 minggu, datang ke Puskesmas untuk kunjungan ulang pemeriksaan kehamilan. Hasil anamnesis: Tidak ada tanda bahaya kehamilan, gerak janin terakhir 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan: TD 120/80 mmHg, N 103 x/menit, P 24 x/menit, S 37,1°C, IMT 19, Kenaikan BB 11 Kg, untuk dilakukan pemeriksaan palpasi abdomen dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan tersebut.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya ketepatan dalam melakukan manuver Leopold, ketelitian penentuan Tinggi Fundus Uteri, presentasi dan bagian terendah janin serta menginterpretasikannya dengan tepat.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengenali bagian-bagian janin, namun perlu ditinngkatkan untuk melatih kepekaan perabaan dalam

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Prosedur pemeriksaan palpasi abdomen
		menentukan normalitas hasil palpasi abdomen.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu prosedur palpasi abdomen, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menilai kondisi janin, melalui palpasi Leopold, penentuan tinggi fundus uteri, presentasi dan seberapa jauh penurunan bagian terendah.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu menilai kondisi janin, melalui palpasi Leopold, penentuan tinggi fundus uteri, presentasi dan seberapa jauh penurunan bagian terendah.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada portofolio prosedur palpasi abdomen-Leopold mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel. Case Report pada Antenatal care: Palpasi Abdomen menurut Leopold, penentuan Tinggi Fundus Uteri, presentasi janin, dan seberapa jauh penurunan bagian terbawah janin

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu hamil primigravida dengan letak sungsang, mahasiswa belajar menganalisi hasil temuannya melalui praktik pemeriksaan palpasi abdomen.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan normalitas maupun kondisi patologis dari hasil temuan palpasi abdomen.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan hasil palpasi abdomen dengan metode Leopold: TFU 33 cm, teraba kepala, Punggung kiri-Presentasi bokong- di atas PAP .
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan usia kehamilan dengan hasil temuan palpasi -Leopold-TFU

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus ini mahasiswa dapat belajar pentingnya ketepatan dalam melakukan palpasi abdomen menggunakan teknik Leopold dan interpretasinya, penentuan normal/patologisnya letak janin sangat menentukan tindakan selanjutnya.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep pemeriksaan palpasi abdomen, tetapi juga mampu menerapkannya, menginterpretasi dan menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Antenatal care: Palpasi Abdomen menurut Leopold, penentuan Tinggi Fundus Uteri, presentasi janin, dan seberapa jauh penurunan bagian terbawah janin

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus palpasi abdomen ini mahasiswa belajar merefleksikan bahwa kesalahan dalam menerapkan prosedur serta menerjemahkan hasil perabaan dapat menimbulkan kesalahan pengambilan keputusan dan tindakan selanjutnya yang dapat merugikan pasien.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan dalam perabaan, pengenalan bagian kecil janin dan kesalahan interpretasi temuan dapat berdampak besar pada keselamatan ibu dan bayi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah kelainan letak yakni sungsang, sehingga perlu tindakan yang tepat dalam penanganannya.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain hasil palpasi Leopold menunjukkan kondisi patologis
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya ketepatan dalam menerapkan prosedur palpasi Leopold.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada prosedur palpasi Leopold, ketepatan dan ketelitian serta kepekaan perabaan menjadi hal yang sangat menentukan hasil temuan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap 73 rofessional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

D. Rangkuman Materi

Tenaga kesehatan diharapkan kompeten dalam melakukan pemeriksaaan abdomen, yang meliputi : palpasi (Leopold), mengukur tinggi fundus uteri, identifikasi presentasi dan penurunan bagian terendah janin. WHO menjelaskan bahwa setiap kehamilan perlu dilakukan assessment guna mengidentifikasi/deteksi dini faktor risiko kehamilan. Palpasi abdomen menurut Leopold terdiri dari 4 tahapan yakni: 1. Leopold I (Menentukan Tinggi Fundus dan bagian janin di fundus) . Tujuannya untuk mendeteksi tinggi fundus uteri dan bagian kutub janin mana yang ada di fundus. 2. Leopold 2 (Menentukan Posisi Punggung) Tujuannya untuk menentukan posisi tulang belakang dan anggota tubuh janin, seperti kanan atau kiri, dan letak janin, seperti memanjang, melintang, atau miring. 3. Leopold 3 (Menentukan Bagian Terbawah). Bertujuan mengidentifikasi presentasi janin / menentukan bagian janin apa yang berada di bagian bawah rahim dan apakah bagian tersebut sudah "masuk" ke pintu atas panggul (PAP). D. Leopold IV (menentukan seberapa jauh masuk panggul). Tujuan utamanya adalah memastikan sejauh mana bagian terbawah janin telah masuk ke dalam pintu atas panggul (PAP), membantu mengidentifikasi presentasi janin. Setiap mahasiswa kebidanan diharapkan dapat melakukan palpasi dengan tepat serta menginterpretasikannya dengan benar. Kesalahan dalam menilai maupun meninterpretasikan hasil temuan dapat berakibat fatal terhadap ibu dan janin serta terjadi kesalahan dalam penatalaksanaan selanjutnya. Ibu dengan letak janin yang diluar normal, harus dapat diidentifikasi pada saat kunjungan antenatal care dan mendapatkan tindak lanjut yang tepat. Ketepatan dalam penerapan prosedur ini sangat menentukan kesejahteraan ibu dan janin selanjutnya sampai masa persalinan.

Alur asuhan singkat

Ibu hamil Usia kehamilan 36 minggu → memerlukan assesment → Palpasi Abdomen → palpasi Leopold → Tentukan hasil temuan Leopold 1 s.d 4, TFU, Presentasi, Penurunan bagian terbawah janian → tentukan kebutuhan mandiri/kolaborasi/rujukan → dokumentasi dan handover yang jelas.

E. Daftar Pustaka

FIGO (2026). Leadership Develompment initiative: Rempving barriers to effective access and coverage of maternal healthcare (LDI: REACH).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. (2020). *Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020*. Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. (2022). *Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022*. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan*.

Kemenkes RI (2020). Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu.

Shevonne S. Superville, Marco A. Siccardi. (2024).*Manuver Leopold.* NCBI

World Health Organization. (2008). *Education material for teachers of midwifery:*

World Health Organization. (2017). *Managing complications in pregnancy and childbirth: A guide for midwives and doctors* (2nd ed.).

World Health Organization. (2017). *Guidelines For Antenatal Care: .*

World Health Organization. (2016).WHO Recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience

World Health Organization. (2021). Digital Adaptation Kit for Antenatal Care: Operational requirements for implementing WHO recommendations in digital system

BAB 5

PENILAIAN KESEJAHTERAAN JANIN: DJJ, GERAK JANIN, DAN PEMANTAUAN PERTUMBUHAN

CPL

CPL 1 : Menguasai konsep ilmiah dan evidence-based terkait pemeriksaan antenatal terpadu.

CPL 2 : Mampu melaksanakan pemeriksaan antenatal terpadu secara sistematis, aman, dan efektif.

CPL 3 : Mampu menginterpretasi temuan klinis dan penunjang untuk mengenali masalah serta risiko kehamilan.

CPL 4 : Mampu menetapkan tindak lanjut, intervensi awal, dan rencana rujukan berdasarkan hasil pemeriksaan.

CPMK

CPMK 4 : Melaksanakan pemeriksaan abdomen obstetri dan penilaian kesejahteraan janin secara sistematis serta menginterpretasi hasil pemantauan klinis.

CPMK 5 : Menginterpretasi hasil pemeriksaan penunjang kehamilan (laboratorium dasar dan USG) dan mengintegrasikannya dengan temuan klinis.

CPMK 6 : Mengidentifikasi tanda bahaya dan masalah prioritas pada kehamilan (termasuk hipertensi/preeklamsia, anemia/gizi, keluhan umum) serta menetapkan tindak lanjut awal dan kebutuhan rujukan.

Uraian Materi

A. DJJ

1. Fisiologi Denyut Jantung Janin

a. Mekanisme Pengaturan oleh Sistem Saraf Otonom

Denyut jantung janin mulai muncul pada usia kehamilan sekitar 5–6 minggu. Tenaga kesehatan dapat mendeteksi aktivitas jantung tersebut melalui pemeriksaan ultrasonografi transvaginal pada awal kehamilan. Sistem saraf otonom mengatur frekuensi dan ritme denyut jantung janin selama perkembangan intrauterin. Sistem saraf otonom terdiri atas dua komponen utama yang memiliki fungsi fisiologis yang saling berlawanan, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis (Jia et al., 2023).

Sistem saraf simpatis meningkatkan frekuensi denyut jantung dan kekuatan kontraksi miokardium janin. Aktivitas simpatis biasanya meningkat ketika janin melakukan gerakan, mengalami stres ringan, atau menghadapi kondisi hipoksia tahap awal. Sistem saraf parasimpatis melalui nervus vagus menurunkan frekuensi denyut jantung sekaligus menghasilkan variasi interval antara satu denyut dengan denyut berikutnya. Variasi denyut tersebut dikenal sebagai variabilitas denyut jantung janin. Keseimbangan aktivitas antara sistem saraf simpatis dan parasimpatis mencerminkan integritas jalur neurologis yang menghubungkan korteks serebral, batang otak, hingga jantung janin (Jia et al., 2023).

Usia kehamilan yang semakin bertambah menyebabkan peningkatan variabilitas denyut jantung janin. Peningkatan variabilitas tersebut terjadi akibat perkembangan tonus parasimpatis yang berlangsung secara bertahap selama masa kehamilan. Janin prematur biasanya menunjukkan variabilitas denyut jantung yang lebih rendah dibandingkan janin aterm pada pemeriksaan kardiotokografi (CTG). Kondisi ini mencerminkan kematangan sistem saraf otonom yang belum sepenuhnya berkembang pada janin prematur. Variabilitas yang rendah pada usia kehamilan dini tidak selalu menunjukkan adanya hipoksia, tetapi sering berkaitan dengan proses maturasi neurologis janin yang masih berlangsung (Jia et al., 2023).

b. Peran Oksigenasi Janin dan Sirkulasi Utero-Plasenta

Kesejahteraan janin sangat dipengaruhi oleh kecukupan perfusi plasenta selama masa kehamilan. Plasenta berfungsi sebagai organ utama yang memfasilitasi pertukaran oksigen, nutrisi, dan produk sisa metabolisme

antara ibu dan janin. Proses pertukaran oksigen antara ibu dan janin berlangsung di ruang intervilosa melalui mekanisme difusi pasif. Luas permukaan vili korionik serta kelancaran aliran darah pada area tersebut memengaruhi efektivitas proses pertukaran ini (Melamed et al., 2021). Gangguan perfusi plasenta dapat menurunkan suplai oksigen yang diterima oleh janin. Kondisi tersebut dapat terjadi pada beberapa keadaan klinis seperti hipertensi maternal, insufisiensi plasenta, solusio plasenta, maupun *supine hypotension* pada ibu hamil. Penurunan suplai oksigen akan memengaruhi kondisi fisiologis janin dan memicu perubahan pada pola denyut jantung janin (Melamed et al., 2021).

Hipoksia pada janin berkembang dapat terjadi secara bertahap melalui mekanisme kompensasi fisiologis yang relatif dapat diprediksi. Aktivasi sistem saraf simpatis pada tahap awal menyebabkan peningkatan frekuensi denyut jantung atau takikardia sebagai upaya mempertahankan oksigenasi jaringan. Tubuh janin kemudian melakukan redistribusi aliran darah menuju organ-organ vital seperti otak, jantung, dan kelenjar adrenal. Proses ini dikenal sebagai mekanisme sentralisasi sirkulasi janin. Cadangan energi janin akan semakin menurun apabila kondisi hipoksia berlangsung lebih lama. Penurunan cadangan energi akhirnya memicu terjadinya asidosis metabolik pada janin. Kondisi tersebut ditandai dengan munculnya bradikardia serta penurunan variabilitas denyut jantung janin pada pemantauan kardiotokografi (CTG) (Jia et al., 2023).

2. Metode Pemantauan DJJ

a. Fetoskop Pinard

Fetoskop Pinard merupakan alat akustik sederhana yang digunakan untuk mendengarkan denyut jantung janin tanpa memerlukan sumber listrik. Alat ini dikenal karena harganya terjangkau, mudah dibawa, serta tersedia hampir di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut WHO (2022), fetoskop Pinard masih layak digunakan untuk pemantauan denyut jantung janin pada masa antenatal, terutama di fasilitas dengan keterbatasan sumber daya (WHO, 2022). Dalam penggunaannya, auskultasi dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

1) Bidan melakukan palpasi Leopold untuk mengetahui letak punggung janin.
2) Ujung corong fetoskop ditempelkan langsung pada permukaan abdomen ibu, tepat di area punggung janin.

3) Pemeriksaan dilakukan di antara kontraksi agar suara lebih jelas, kemudian denyut jantung dihitung selama satu menit penuh.
4) Hasil yang diperoleh meliputi frekuensi, keteraturan, serta waktu pemeriksaan, yang kemudian dicatat.

Meski praktis, alat ini memiliki keterbatasan, yaitu tidak mampu menilai variabilitas maupun pola deselerasi denyut jantung, serta lebih sulit digunakan pada ibu dengan obesitas atau posisi plasenta anterior (Kemenkes RI, 2020).

b. Doppler Portabel

Doppler portabel bekerja dengan memanfaatkan prinsip efek Doppler ultrasonik, yaitu perubahan frekuensi gelombang yang dipantulkan dari katup jantung janin yang sedang bergerak, kemudian diubah menjadi sinyal suara yang dapat didengar. Alat ini mampu mendeteksi denyut jantung janin sejak usia kehamilan sekitar 10–12 minggu, sehingga lebih sensitif dibandingkan fetoskop. Agar hasil pemeriksaan tetap akurat, alat ini perlu dikalibrasi secara rutin (Hayes et al., 2023).

Dalam penggunaan doppler portable dilakukan melalu langkah berikut:

1) Pemeriksaan diawali dengan mengoleskan gel konduktor pada area abdomen ibu.
2) Probe kemudian ditempatkan di atas punggung janin dengan kemiringan sekitar 45°, lalu digerakkan perlahan hingga terdengar suara denyut jantung yang jelas.
3) Setelah itu, frekuensi denyut dapat dihitung selama satu menit penuh atau dibaca langsung melalui tampilan digital jika tersedia.
4) Setelah pemeriksaan selesai, gel dibersihkan dari permukaan kulit.

c. Cardiotocography (CTG)

CTG digunakan untuk merekam denyut jantung janin secara kontinu bersamaan dengan aktivitas uterus melalui dua transduser yang berbeda. Hasil pemeriksaan akan ditampilkan dalam bentuk grafik dua saluran, sehingga memungkinkan analisis pola denyut jantung janin secara lebih menyeluruh. Pemeriksaan ini tidak dilakukan secara rutin pada setiap kunjungan antenatal, melainkan pada kondisi tertentu, terutama pada kehamilan dengan risiko tinggi. Indikasinya meliputi hipertensi atau preeklamsia, diabetes, pertumbuhan janin terhambat (FGR), kehamilan lewat waktu, perdarahan antepartum, serta keluhan penurunan gerakan janin (Heney et al., 2022). Dalam interpretasinya, terdapat lima komponen utama yang perlu diperhatikan, yaitu:

1) Baseline fetal heart rate, yaitu rata-rata denyut jantung janin dalam rentang 10 menit dengan nilai normal antara 110–160 denyut per menit.
2) Variabilitas, yang menggambarkan fluktuasi kecil di sekitar baseline dan mencerminkan fungsi sistem saraf pusat, dengan kisaran normal 6–25 denyut per menit.
3) Akselerasi, yaitu peningkatan denyut jantung minimal 15 denyut per menit selama setidaknya 15 detik, yang menunjukkan respons janin yang baik.
4) Deselerasi yang dapat berupa early, variable, late, maupun prolonged.
5) Pola sinusoidal yang sangat jarang ditemukan, namun perlu diwaspadai karena dapat mengindikasikan anemia berat pada janin (Jia et al., 2023).

3. Nilai Normal DJJ dan Intepretasinya

a. Bradikardia Janin

Bradikardia didefinisikan sebagai denyut jantung janin kurang dari 110 denyut per menit yang berlangsung lebih dari 10 menit. Penurunan yang bersifat sementara, terutama yang terjadi kurang dari 3 menit, umumnya merupakan respons refleks vagal akibat tekanan pada kepala janin dan biasanya tidak membahayakan. Bila kondisi ini menetap, hal tersebut dapat mengindikasikan masalah serius seperti hipoksia berat, blok jantung kongenital yang dapat berkaitan dengan lupus eritematosus sistemik pada ibu atau adanya pengaruh obat-obatan seperti beta-blocker dan anestesi local (Jia et al., 2023).

b. Takikardia Janin

Takikardia pada janin diartikan sebagai denyut jantung lebih dari 160 denyut per menit yang berlangsung lebih dari 10 menit. Kondisi ini paling sering dipicu oleh beberapa faktor. Demam pada ibu merupakan penyebab yang umum, di mana setiap peningkatan suhu tubuh sebesar 1°C dapat menaikkan denyut jantung janin sekitar 10 denyut per menit. Infeksi pada janin atau korioamnionitis juga perlu dicurigai, terutama jika takikardia disertai demam dan nyeri tekan pada uterus. Pada tahap awal hipoksia, takikardia dapat muncul sebagai respons kompensasi melalui aktivasi sistem saraf simpatis. Penggunaan obat-obatan tertentu, seperti betamimetik (misalnya terbutalin) atau atropin, juga dapat memicu peningkatan denyut jantung janin (Jia et al., 2023).

B. Gerak Janin

1. Fisiologi dan Perkembangan Gerak Janin

a. Perkembangan Gerak Berdasarkan Usia Gestasi

Gerakan janin dapat dideteksi sejak usia kehamilan sekitar 7–8 minggu melalui pemeriksaan USG, yang tampak sebagai gerakan umum seluruh tubuh pada janin itu sendiri. Ibu hamil biasanya mulai merasakannya secara langsung (quickening) pada usia 16–20 minggu. Pada ibu yang sudah pernah hamil sebelumnya (multigravida), sensasi ini cenderung dirasakan lebih awal, sekitar 16–18 minggu, karena pengalaman sebelumnya membuat mereka lebih peka terhadap pergerakan janin (Tsakiridis et al., 2022). Frekuensi gerakan janin mencapai puncaknya pada usia kehamilan 28–34 minggu, kemudian sedikit menurun menjelang aterm seiring berkurangnya ruang dalam rongga amnion.

Hal yang penting untuk dipahami dan disampaikan kepada ibu adalah bahwa kualitas dan kekuatan gerakan janin tidak seharusnya menurun menjelang persalinan. Anggapan bahwa gerakan janin "normal berkurang" saat mendekati waktu melahirkan merupakan mitos yang keliru dan dapat berbahaya, karena berisiko membuat ibu terlambat melaporkan penurunan gerakan janin (DFM) (Bradford et al., 2024).

b. Gerak Janin sebaga Cerminan Oksigenasi dan Integritas Neurologis

Gerakan janin merupakan hasil dari koordinasi neuromuskular yang kompleks, yang sangat bergantung pada kecukupan suplai oksigen serta integritas sistem saraf pusat. Ketika terjadi hipoksia, aktivitas korteks serebral akan menurun secara bertahap dengan pola yang relatif dapat diprediksi, dimulai dari berkurangnya gerakan halus seperti pernapasan dan gerakan mata, diikuti penurunan gerakan kasar, hingga akhirnya memengaruhi tonus tubuh (Bradford et al., 2024). Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa penurunan gerakan janin (DFM) sering kali muncul beberapa hari hingga minggu sebelum terjadinya stillbirth.

Terdapat bukti ilmiah kuat yang mendukung hal ini. Hasil meta-analisis yang dilakukan oleh Thompson et al, (2021) dengan basis data individual yang melibatkan 851 kasus stillbirth menunjukkan bahwa persepsi ibu terhadap penurunan frekuensi gerakan janin berkaitan dengan peningkatan risiko late stillbirth secara signifikan (adjusted OR 4,51; 95% CI 2,38–8,55) (Thompson et al., 2021). Risiko ini bahkan jauh lebih tinggi pada janin dengan berat lahir di bawah persentil ke-25, dengan adjusted OR mencapai 9,34 pada kuartil terendah (95% CI 5,43–16,06).

Temuan ini menegaskan hubungan erat antara DFM, gangguan pertumbuhan janin (FGR), dan risiko stillbirth (Bradford et al., 2024).

Tinjauan sistematis dan meta-analisis yang dilakukan oleh Hayes et al, (2023) yang mencakup berbagai jenis studi menyimpulkan bahwa upaya meningkatkan kesadaran ibu terhadap DFM dapat mendorong mereka untuk lebih cepat mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan. Intervensi ini juga berpotensi menurunkan angka perawatan di NICU serta kejadian skor APGAR kurang dari 7, meskipun dampaknya terhadap penurunan angka stillbirth secara langsung masih belum dapat dipastikan (Hayes et al., 2023).

c. Factor yang Mempengaruhi Persepsi Ibu terhadap Gerak Janin

Memahami berbagai faktor yang memengaruhi persepsi ibu terhadap gerakan janin sangatlah penting. Hal tersebut bertujuan agar bidan tidak keliru dalam menafsirkan laporan yang disampaikan oleh ibu hamil itu sendiri (Tsakiridis et al., 2022). Berikut adalah beberapa faktor yag mempengaruhi persepsi ibu terhadap gerak janin.

1) Posisi plasenta

Posisi plasenta turut berperan dalam sensasi gerak janin yang dirasakan oleh ibu hamil. Pada plasenta anterior, getaran gerakan janin cenderung teredam, sehingga gerakan biasanya dirasakan lebih lambat dan kurang kuat dibandingkan dengan plasenta posterior.

2) Indeks massa tubuh (IMT) ibu

IMT pada ibu hamil juga dapat memengaruhi persepsi ibu hamil terhadap gerak janin. Lapisan lemak abdomen yang lebih tebal dapat mengurangi penghantaran getaran, sehingga ibu dengan obesitas (IMT ≥ 30) mungkin merasakan gerakan lebih sedikit meskipun janin sebenarnya aktif.

3) Posisi tubuh ibu

Posisi ibu hamil saat merasakan Gerakan janin turut menentukan persepsi gerak janin pada ibu hamil itu sendiri. Berbaring miring ke kiri dapat meningkatkan curah jantung dan perfusi plasenta, sehingga janin cenderung lebih aktif. Sebaliknya, posisi duduk tegak atau berdiri dapat menurunkan kepekaan ibu terhadap gerakan tersebut.

4) Siklus tidur dan bangun janin

Siklus tidur dan bangun janin merupakan faktor fisiologis yang normal. Janin memiliki periode tidur selama 20–40 menit (ritme ultradian), di mana aktivitas gerakan akan berkurang. Oleh karena itu, batas waktu

pengamatan hingga 12 jam (metode Cardiff) dirancang untuk mencakup beberapa siklus ini.

5) **Aktivitas ibu sehari-hari**

Aktivitas ibu sehari – hari juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam mempengaruhi persepsi ibu terhadap gerak janin. Saat ibu sedang aktif bergerak atau sibuk, perhatian terhadap gerakan janin bisa berkurang. Sebaliknya, gerakan lebih mudah dirasakan ketika ibu berada dalam kondisi istirahat dan tenang.

6) **Penggunaan obat-obatan tertentu**

Penggunaan obat seperti sedatif, opioid, kortikosteroid antenatal, alkohol, maupun nifedipin dapat menurunkan aktivitas motorik janin secara sementara, tanpa selalu menunjukkan kondisi patologis.

2. Metode Pemantauan Gerak Janin

a. Cardiff Conut-to-Ten

Metode *Cardiff Count-to-Ten* merupakan cara pemantauan gerakan janin yang paling banyak direkomendasikan karena praktis, tidak memerlukan alat, dan dapat dilakukan sendiri oleh ibu di rumah (AWHONN, 2024). Berikut adalah langkah – langkah yang dapat diajarkan kepada ibu hamil untuk memantau gerak janinnya.

1) Penghitungan dimulai sejak ibu bangun pagi, dengan posisi yang dirasa paling nyaman.
2) Semua bentuk gerakan janin dihitung, seperti tendangan, putaran, tonjolan, atau sensasi bergelombang. Namun, cegukan tidak termasuk dalam hitungan.
3) Ibu diminta mencatat waktu saat gerakan pertama dirasakan hingga tercapainya gerakan ke-10.
4) Jika 10 gerakan sudah tercapai dalam waktu relatif singkat, maka pemantauan untuk hari tersebut dapat dihentikan.
5) Apabila dalam waktu 12 jam belum mencapai 10 gerakan, atau ibu merasa pola gerakan berbeda dari biasanya, maka disarankan untuk segera menghubungi bidan.

b. Penggunaan Kick Chart

Kick chart merupakan lembar pencatatan harian untuk memonitor gerakan janin yang umumnya mulai digunakan sejak usia kehamilan 28 minggu. Penggunaan *kick chart* juga memberikan manfaat psikologis, karena dapat memperkuat ikatan emosional antara ibu dan janin (Hayes et al., 2023).

3. Decreased Fetal Movement (DFM)

a. Definisi DFM

Panduan klinis terbaru menetapkan beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai penurunan gerakan janin atau DFM (AWHONN, 2024). Pada metode Cardiff, DFM dicurigai bila kurang dari 10 gerakan dalam 12 jam pengamatan aktif. Pendapat lain menyebutkan bahwa menurut metode Sadovsky, batasnya adalah kurang dari 4 gerakan dalam satu sesi pengamatan selama 1 jam. Selain pendekatan kuantitatif, penilaian juga sangat mempertimbangkan persepsi subjektif ibu, yaitu ketika ibu merasa pola gerakan janinnya berbeda atau lebih sedikit dari biasanya.

Hal yang perlu menjadi perhatian utama adalah bahwa laporan subjektif ibu tidak boleh diabaikan, meskipun belum memenuhi kriteria angka tertentu. Ibu adalah pihak yang paling mengenali pola gerakan janinnya sendiri, sehingga perubahan sekecil apa pun tetap memiliki makna klinis. Evaluasi kesejahteraan janin sebaiknya dilakukan maksimal dalam waktu 2 jam setelah ibu melaporkan adanya penurunan gerakan janin (AWHONN, 2024).

b. Alur dan Tindak Lanjut DFM dalam ANC

Menurut AWHONN, (2024), berikut adalah alur pelayanan dan tindak lanjut DFM dalam ANC ketika ibu datang dengan keluhan penurunan gerakan janin (DFM), bidan perlu melakukan penatalaksanaan secara sistematis dan berurutan diantaranya adalah:

1) Langkah pertama dimulai dengan anamnesis terstruktur, meliputi waktu terakhir ibu merasakan gerakan janin, apakah penurunannya terjadi secara mendadak atau bertahap, riwayat penggunaan obat-obatan, serta apakah sebelumnya pernah mengalami DFM.
2) Segera lakukan auskultasi denyut jantung janin (DJJ) dengan menilai frekuensi dan keteraturannya selama minimal 60 detik. Jika DJJ dalam batas normal, bidan dapat melakukan stimulasi janin, misalnya dengan menganjurkan ibu mengonsumsi minuman manis, melakukan palpasi ringan, atau berbaring miring ke kiri selama sekitar 30 menit.
3) Apabila setelah stimulasi gerakan janin kembali dirasakan dan DJJ tetap normal, ibu diberikan edukasi, dianjurkan melakukan pemantauan menggunakan *kick chart*, serta dijadwalkan kontrol ulang lebih awal.
4) Jika DJJ menunjukkan kelainan atau gerakan janin tetap tidak dirasakan setelah 30 menit stimulasi, maka perlu dilakukan

pemeriksaan lanjutan seperti NST (bila tersedia) atau dirujuk untuk evaluasi lebih lanjut dengan USG/NST.

5) Dalam kondisi yang lebih gawat, seperti DJJ kurang dari 100 denyut per menit atau bahkan tidak terdengar, bidan harus segera melakukan rujukan tanpa menunda dengan observasi tambahan, karena hal ini mengarah pada kemungkinan distres janin (AWHONN, 2024).

4. Edukasi Ibu tentang Gerak Janin

Edukasi mengenai pemantauan gerakan janin merupakan salah satu intervensi sederhana dengan biaya rendah, namun memiliki dampak klinis yang besar dalam upaya pencegahan *stillbirth* (Bradford et al., 2024). Materi ini perlu selalu disampaikan pada setiap kunjungan antenatal, terutama setelah usia kehamilan mencapai 28 minggu. Beberapa poin penting yang wajib dipahami ibu antara lain:

a. Gerakan janin yang aktif merupakan salah satu tanda bahwa kondisi bayi dalam keadaan baik.
b. Ibu dianjurkan mulai memantau gerakan janin secara sadar setiap hari sejak usia kehamilan 28 minggu.
c. Waktu yang paling ideal untuk merasakan gerakan adalah setelah makan, dengan posisi berbaring miring ke kiri.
d. Secara umum, gerakan yang dianggap normal adalah minimal 10 kali dalam 12 jam pengamatan.
e. Ibu tidak boleh menunda untuk mencari pertolongan jika merasa gerakan janin berkurang atau berbeda dari biasanya dan tidak perlu menunggu hingga keesokan hari.
f. Penting untuk diluruskan bahwa anggapan gerakan janin akan berkurang menjelang persalinan adalah mitos yang keliru dan dapat membahayakan, karena berisiko menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi masalah pada janin.

C. Pemantauan Pertumbuhan

1. Konsep Dasar Pertumbuhan Janin

Pertumbuhan janin merupakan proses biologis kompleks yang dimulai sejak terjadinya fertilisasi hingga kelahiran, yang melibatkan interaksi dinamis antara faktor genetic, lingkungan intrauterinm dan kondisi maternal itu sendiri (Cunningham et al., 2019; Moore et al., 2020). Secara konsep, proses pertumbuhan janin tidak hanya mencerminkan peningkatan ukuran dan berat janin saja, tetapi juga mencakup diferensiasi seluler dan maturase organ yang

berlangsung secara bertahap sesuai dengan usia getasi janin (Hall, J. E., & Hall, 2020).

a. Fase Pertumbuhan Janin

Fase pertumbuhan janin secara fisiologis terbagi menjadi tiga fase, diantaranya adalah fase hyperplasia, fase hyperplasia dan hipertrofi dan fase hipertrofi (Melamed et al., 2021). Secara fisiologis fase pertumbuhan janin masing – masing memiliki implikasi klinis yang berbeda – beda pada setiap fasenya. Berikut adalah beberapa fase dari pertumbuhan janin :

1) Fase Hiperplasia

Fase hyperplasia merupakan fase yang terjadi di usia kehamilan 0 – 16 minggu. Pada fase hyperplasia, pembelahan sel terjadi sangat cepat dimana sel membelah dari pembelahan 2 – sel, 4 – sel, 8 – sel dan seterusnya di tuba falopi. Pada fase ini beberapa gangguan yang mungkin rentan terjadi pada embrio diantaranya adalah infeksi TORCH awal, paparan teratogen, defisiensi nutrisi berat yang dapat menyebabkan pengurangan jumlah sel yang permanen dan ireversibel.

2) Fase Hiperplasia dan Hipertrofi

Fase hyperplasia dan hipertrofi adalah fase dimana pembelahan sel berlanjut bersamaan dengan peningkatan ukuran sel. Fase ini berlangsung pada minggu ke 16 – 32 kehamilan dengan pertumbuhan tercepat terjadi pada periode akselerasi. Insufisiensi plasenta pada fase ini menghasilkan FGR yang cukup signifikan secara klinis.

3) Fase Hipertrofi

Fase hipertrofi merupakan fase yang terjadi pada usia kehamilan 32 – 40 minggu. Fase ini ditandai dengan melambatnya proses pembelahan sel. Pada tahap ini, pertumbuhan janin utama terjadi melalui peningkatan ukuran sel, yang ditunjukkan dengan penimbunan lemak subkutan, penyimpanan glikogen di hati, serta bertambahnya massa organ. Selama trimester akhir, berat badan janin umumnya meningkat sekitar ±200 gram per minggu. Pada fase ini pula, *fetal growth restriction* (FGR) tipe *late-onset*, yang sering berkaitan dengan kondisi hipertensi kronik pada ibu, mulai tampak secara klinis.

b. Factor Penentu Pertmbuhan Janin

Menurut (Melamed et al., 2021), terdapat 3 faktor yang dapat menentukan pertumbuhan janin yang diantaranya adalah :

1) Factor Genetik

Faktor genetic merupakan faktor yang menyumbang hingga 40% pada penentu pertumbuhan janin, sehingga sangat mempengaruhi potensi pertumbuhan janin yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Jika orang tua memiliki postur tubuh kecil secara alami, maka janin biasanya juga berukuran lebih kecil. Namun, kondisi ini tetap dianggap normal selama pertumbuhan janin berlangsung seimbang dan proporsional, yang dikenal sebagai *small for gestational age* (SGA) konstitusional. Hal ini berbeda dengan *fetal growth restriction* (FGR) yang terjadi karena adanya gangguan tertentu, sehingga pertumbuhan janin menjadi tidak optimal dan berisiko terhadap kesehatannya.

2) Factor Plasenta

Plasenta merupakan faktor utama yang menentukan pertumbuhan janin. Fungsinya dipengaruhi oleh luas permukaan vili korionik, kelancaran aliran darah di ruang intervilosa, serta kemampuan dalam menyalurkan nutrisi dari ibu ke janin. Apabila terjadi gangguan pada fungsi plasenta, kondisi ini menjadi penyebab paling umum terjadinya *fetal growth restriction* (FGR).

3) Factor Maternal

Faktor maternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan janin dan menjadi faktor yang cukup kompleks. Beberapa aspek penting yang tergolong dalam faktor maternal diantaranya adalah status gizi, kondisi medis, kebiasaan dan pola hidup serta usia ibu. Status gizi ibu, seperti kecukupan asupan kalori, protein, zat besi, asam folat, dan zinc, berperan langsung dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin secara optimal. Kekurangan zat gizi tersebut dapat menghambat proses pembentukan jaringan dan organ janin.

Kondisi medis yang dialami ibu, seperti hipertensi kronik, diabetes melitus, anemia berat, dan penyakit autoimun, dapat memengaruhi aliran darah serta suplai oksigen dan nutrisi ke janin, sehingga berpotensi mengganggu pertumbuhannya. Kebiasaan hidup yang tidak sehat, seperti merokok dan konsumsi alkohol, juga diketahui dapat menurunkan kualitas lingkungan intrauterin dan meningkatkan risiko gangguan pertumbuhan janin. Aspek lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan pertumbuhan janin adalah usia ibu. Usia ibu turut menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Kehamilan pada usia terlalu muda maupun usia lanjut memiliki risiko lebih tinggi terhadap berbagai komplikasi, termasuk hambatan pertumbuhan

janin. Oleh karena itu, keseluruhan faktor maternal ini perlu dikaji secara komprehensif untuk mendukung tumbuh kembang janin yang optimal.

c. Membedakan FGR dan SGA

Fetal growth restriction (FGR) didefinisikan sebagai kondisi ketika janin gagal mencapai potensi pertumbuhan genetik yang seharusnya akibat faktor patologis, dengan penyebab tersering berupa disfungsi plasenta (Melamed et al., 2021). Kondisi ini mencerminkan adanya gangguan pada proses fisiologis yang memengaruhi suplai oksigen dan nutrisi pada janin, sehingga pertumbuhan janin tidak berlangsung secara optimal (Visser et al., 2014).

Berbeda dengan FGR, istilah *small for gestational age* (SGA) didefinisikan sebagai ukuran janin atau neonatus yang berada di bawah persentil ke-10 sesuai usia gestasi, tanpa mempertimbangkan penyebab yang mendasarinya (Melamed et al., 2021). Dengan demikian, tidak semua janin SGA mengalami gangguan patologis, karena sebagian dapat merupakan variasi normal yang dipengaruhi faktor genetik atau konstitusional (Gordijn et al., 2016).

Segi implikasi klinis menunjukan bahwa, perbedaan antara SGA dan FGR sangat penting untuk menentukan penatalaksanaan kebidanan. Bayi dengan SGA konstitusional umumnya hanya memerlukan pemantauan pertumbuhan dan kondisi secara berkala, tanpa intervensi segera, selama tidak ditemukan tanda gangguan kesejahteraan janin (Visser et al., 2014). Sebaliknya, janin dengan FGR yang disertai tanda hipoksia atau insufisiensi plasenta memerlukan evaluasi yang lebih mendalam serta pertimbangan intervensi, termasuk kemungkinan persalinan lebih awal untuk mencegah komplikasi yang lebih berat (Melamed et al., 2021).

Pedoman dari SOGC menegaskan bahwa langkah awal yang paling penting dalam mengevaluasi kecurigaan FGR adalah memastikan usia kehamilan secara akurat, yang idealnya ditentukan melalui pemeriksaan ultrasonografi pada trimester pertama (Kingdom et al., 2023). Penentuan usia gestasi yang tepat menjadi dasar utama dalam menilai apakah pertumbuhan janin sesuai dengan usia kehamilan, sehingga dapat menghindari kesalahan diagnosis dan menentukan strategi penatalaksanaan yang tepat.

2. Teknik Pengukuran TFU (McDonald's Method)

Pengukuran tinggi fundus uteri (TFU) merupakan salah satu metode pemeriksaan klinis yang sederhana, noninvasif, dan banyak digunakan dalam

pemantauan pertumbuhan janin selama masa kehamilan (Cunningham et al., 2019; WHO, 2016). Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam pelayanan antenatal karena dapat memberikan gambaran awal mengenai kesesuaian antara usia kehamilan dan pertumbuhan janin secara praktis di fasilitas kesehatan primer maupun lanjutan (ACOG, 2021). Salah satu teknik yang paling umum digunakan dalam pengukuran TFU adalah **metode McDonald**, yaitu teknik pengukuran jarak dari simfisis pubis hingga puncak fundus uteri menggunakan pita ukur fleksibel (Cunningham et al., 2019);(Lowdermilk et al., 2019). Metode ini dinilai praktis, mudah dilakukan, serta memiliki korelasi yang cukup baik dengan usia kehamilan, terutama pada trimester kedua hingga trimester ketiga (WHO, 2016). Dengan menggunakan teknik yang tepat, pengukuran TFU dapat menjadi indikator awal untuk menilai apakah pertumbuhan janin berlangsung sesuai dengan usia gestasi.

a. Dasar Ilmiah Pengukuran TFU

Pengukuran tinggi fundus uteri (TFU) dengan pita ukur yang dikenal sebagai *McDonald's method* merupakan metode skrining tingkat pertama yang banyak digunakan untuk menilai pertumbuhan janin selama masa kehamilan (Cunningham et al., 2019). Tenaga kesehatan memanfaatkan metode ini secara luas dalam pelayanan antenatal karena prosedurnya sederhana, tidak invasif, serta dapat dilakukan secara berulang dalam pemantauan kehamilan rutin (Lowdermilk et al., 2019); (WHO, 2016). Metode pengukuran ini memberikan manfaat yang penting terutama pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan keterbatasan akses terhadap pemeriksaan ultrasonografi (USG) (WHO, 2016).

Pemantauan TFU secara berkala dapat membantu tenaga kesehatan dalam mendeteksi kemungkinan adanya gangguan pertumbuhan janin sejak dini (Ego et al., 2023). Sebuah uji klinis acak kelompok (*cluster-randomised trial*) yang dilakukan di 16 fasilitas perinatal tersier di Perancis mengevaluasi penggunaan pencatatan TFU secara serial pada grafik pertumbuhan yang disesuaikan (Ego et al., 2023). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pencatatan TFU secara serial pada grafik pertumbuhan mampu meningkatkan deteksi antenatal terhadap *fetal growth restriction* (FGR) secara bermakna dibandingkan dengan perawatan standar, dengan nilai *relative risk* sebesar 1,38 dan interval kepercayaan 95% sebesar 1,05–1,80 (Ego et al., 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa interpretasi TFU yang dilakukan secara sistematis dapat meningkatkan sensitivitas skrining terhadap gangguan pertumbuhan janin (Visser et al., 2014).

Proyek penelitian internasional **INTERGROWTH-21st** juga memberikan dasar ilmiah yang kuat dalam penggunaan TFU sebagai alat skrining pertumbuhan janin (Papageorghiou et al., 2016). Peneliti dalam proyek tersebut menyusun standar internasional kurva TFU berdasarkan pengukuran serial pada 4.321 perempuan hamil sehat yang berasal dari delapan negara dengan latar belakang populasi yang berbeda (Papageorghiou et al., 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggi fundus uteri meningkat hampir secara linier seiring dengan bertambahnya usia gestasi, terutama pada trimester kedua hingga trimester ketiga kehamilan (Papageorghiou et al., 2016). Temuan tersebut memperkuat dasar ilmiah penggunaan pengukuran TFU sebagai indikator klinis yang sederhana namun cukup reliabel dalam menilai pertumbuhan janin selama masa kehamilan (WHO, 2016) (Cunningham et al., 2019).

b. Prosedur Pengukuran TFU yang Benar

Pengukuran tinggi fundus uteri (TFU) merupakan salah satu pemeriksaan klinis yang penting dalam pemantauan kehamilan. Pemeriksaan ini membantu tenaga kesehatan menilai kesesuaian antara pertumbuhan janin dan usia gestasi secara sederhana dan praktis. Ketepatan hasil pengukuran sangat bergantung pada teknik pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan benar, sehingga hasil pengukuran yang dilakukan dapat dibandingkan antar kunjungan (Kemenkes RI, 2020).

Pelaksanaan pengukuran TFU memerlukan langkah-langkah prosedural yang jelas, mulai dari persiapan ibu, posisi pemeriksaan, penentuan titik pengukuran, hingga cara membaca hasil pengukuran. Kesalahan dalam teknik pengukuran dapat memengaruhi interpretasi hasil dan berpotensi menimbulkan penilaian yang kurang tepat terhadap pertumbuhan janin. Berikut adalah prosedur pengukuran TFU tang benar :

1) Pastikan kandung kemih ibu hamil kosong. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan hasil yang didapatkan akan lebih akurat, karena kondisi kandung kemih yang terisi penuh dapat menambah 1 – 3 cm hasil pemeriksaan TFU.
2) Posisikan ibu hamil berbaring terlentang di meja periksa yang datar
3) Identifikasi tepi atas simfisis pubis dengan tekanan ringan untuk menentukan titik nol (0) pengukuran.
4) Identifikasi puncak fundus uteri dengan meraba dari epigastrium ke bawah secara bertahap
5) Tempelkan ujung pita ukur non elastis di tepi simfisis pubis
6) Rentangkan pita ukur mengikuti kontur abdomen menuju fundus

Baca hasil dalam satuan centimeter di titik tertinggi fundus dan lakukan dokumentasi.

3. Nilai Normal TFU dan Interpretasi Grafik

Nilai tinggi fundus uteri (TFU) merupakan salah satu indikator klinis yang digunakan untuk menilai kesesuaian antara pertumbuhan janin dan usia kehamilan. Hasil pengukuran TFU yang berada dalam rentang normal menunjukkan bahwa pertumbuhan janin berlangsung sesuai dengan usia gestasi. Sebaliknya, hasil pengukuran yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai yang diharapkan dapat menjadi petunjuk awal adanya kemungkinan gangguan pertumbuhan janin. Pemahaman mengenai nilai normal TFU sangat penting bagi tenaga kesehatan agar dapat melakukan interpretasi hasil pengukuran secara tepat. Pengetahuan ini membantu tenaga kesehatan membedakan antara variasi pertumbuhan yang masih dalam batas normal dengan kondisi yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Berikut adalah nilai normal tinggi fundus uteri (TFU) pada ibu hamil sesuai usia kehamilannya.

a. Nilai Normal Tinggi Fundus Uteri (TFU)

Usia Getasi	**TFU Normal (cm)**	**Posisi Fundus**	**EFW Estimasi**	**Keterangan**
20 Minggu	18 – 22 cm	Setinggi umbilikus	± 300 g	Milestone klinis
24 Minggu	22 – 26 cm	2–3 jari di atas umbilikus	± 600 g	
28 Minggu	26 – 30 cm	Pertengahan umbilik–xiphoid	± 1000 g	Viabilitas janin tercapai
32 Minggu	30 – 34 cm	3/4 jarak umbilik–xiphoid	± 1800 g	
36 Minggu	34 – 37 cm	Hampir mencapai xiphoid	± 2700 g	Kepala mulai masuk PAP
40 Minggu	37 – 40 cm	Turun dari xiphoid (engagement)	± 3400 g	Lightening: TFU turun 2–3 cm

b. Interpretasi Grafik Pertumbuhan

1) Normal (P 10 – P 90)

Interpretasi ini menunjukkan bahwa nilai TFU berada di antara persentil ke-10 hingga persentil ke-90 pada kurva pertumbuhan.

Kondisi tersebut menandakan bahwa pertumbuhan janin masih dalam batas normal. Tenaga kesehatan juga memperhatikan tren kenaikan TFU yang seharusnya mengikuti arah kurva pertumbuhan secara konsisten pada setiap kunjungan antenatal. Pertumbuhan yang mengikuti kurva biasanya menunjukkan perkembangan janin yang baik.

2) Dibawah P 10 – Suspect FGR

Nilai TFU yang berada di bawah persentil ke-10 menunjukkan bahwa ukuran uterus lebih kecil dibandingkan yang diharapkan untuk usia kehamilan. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan terhadap fetal growth restriction (FGR) atau hambatan pertumbuhan janin. Tenaga kesehatan perlu melakukan evaluasi lebih lanjut seperti meninjau kembali usia getasi, menanyakan riwayat ukuran tubuh keluarga dan melakukan pemeriksaan USG Biometri janin untuk memastikan diagnosis yang tepat.

3) Diatas P 90 – Suspect Makrosomia / Polihidramnion

Nilai TFU yang lebih tinggi dari persentil ke-90 menunjukkan ukuran uterus yang lebih besar dari yang seharusnya. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, antara lain makrosomia janin terutama pada ibu dengan diabetes, polihidrammnion atau kemungkinan adanya kesalahan dapam penentuan usia kehamilan. Pada permasalahan ini, evaluasi lanjutan biasanya diperlukan untuk menentukan penyebabnya.

4) Tren Datar / Plateau

Interpretasi ini tidak hanya melihat nilai TFU, tetapi juga perubahan TFU dari waktu ke waktu. TFU seharusnya meningkat seiring bertambahnya usia kehamilan. Kondisi tren datar terjadi ketika TFU tidak mengalami peningkatan pada dua kunjungan berturut-turut dengan jarak minimal dua minggu. Keadaan ini dianggap sebagai tanda peringatan (red flag) yang dapat mengindikasikan FGR, meskipun nilai TFU masih berada dalam rentang normal.

4. Estimasi Berat Janin Secara Klinis (Rumus Johnson)

Estimasi berat janin merupakan salah satu parameter penting dalam pemantauan kehamilan dan perencanaan persalinan. Estimasi berat janin membantu tenaga kesehatan menilai kondisi janin serta memprediksi kemungkinan komplikasi selama persalinan (Pavithra et al., 2022). Berat janin yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi meningkatkan risiko morbiditas dan

mortalitas perinatal sehingga penilaian berat janin sebelum persalinan memiliki nilai klinis yang penting (Sehrawat & Panchanadikar, 2020). Rumus Johnson merupakan metode klinis yang memperkirakan berat janin berdasarkan hasil pengukuran tinggi fundus uteri dan posisi kepala janin terhadap panggul ibu. Metode ini memanfaatkan hubungan antara ukuran uterus dan pertumbuhan janin pada akhir masa kehamilan (Pavithra et al., 2022). Berikut adalah rumus yang dapat digunakan untuk menentukan estimasi berat janin pada ibu hamil

Berat Janin (Gram) : (Tinggi Fundus Uteri – N) x 155

Keterangan :

Nilai N ditentukan berdasarkan posisi kepala janin pada panggul ibu. Terdapat 3 nilai N dalam rumus Johnson diantaranya adalah :

a. N = 11 jika kepala janin sebagian besar sudah masuk ke Pintu Atas Panggul
b. N = 12 jika kepala janin sejajar sudah masuk ke Pintu Atas Panggul
c. N = 13 jika kepala janin belum masuk ke Pintu Atas Panggul

5. Integrasi dengan USG dan Indikasi USG

Tenaga kesehatan sering menggunakan pemeriksaan ultrasonografi (USG) sebagai metode utama dalam penilaian pertumbuhan janin secara objektif selama masa kehamilan. Pemeriksaan ini memberikan gambaran anatomi dan ukuran janin secara lebih akurat dibandingkan pemeriksaan klinis semata (Melamed et al., 2021). Tenaga kesehatan sering mengombinasikan pemeriksaan klinis, seperti pengukuran tinggi fundus uteri (TFU), dengan pemeriksaan USG untuk meningkatkan ketepatan penilaian kondisi janin (Kingdom et al., 2023). Pada pemeriksaan USG biometri janin, tenaga kesehatan akan menilai beberapa parameter anatomi utama untuk memperkirakan ukuran dan berat janin. Tenaga kesehatan mengukur empat parameter biometri utama dalam pemeriksaan ini, yaitu **biparietal diameter (BPD), head circumference (HC), abdominal circumference (AC)**, dan **femur length (FL)** (Melamed et al., 2021). Parameter BPD menggambarkan diameter kepala janin dari satu tulang parietal ke tulang parietal lainnya. Parameter HC menunjukkan lingkar kepala janin yang mencerminkan pertumbuhan otak dan struktur kranium. Parameter FL menggambarkan panjang tulang femur sebagai indikator pertumbuhan tulang panjang janin *(Cunningham et al., 2022; Salomon et al., 2019)*.

Parameter **abdominal circumference (AC)** memiliki sensitivitas paling tinggi dalam mendeteksi gangguan pertumbuhan janin. Lingkar perut janin

mencerminkan ukuran hati dan cadangan glikogen yang tersimpan pada organ tersebut. Penurunan nilai AC sering menunjukkan adanya gangguan suplai nutrisi dan oksigen akibat insufisiensi plasenta sehingga parameter ini menjadi indikator awal terjadinya *fetal growth restriction* (FGR) (Melamed et al., 2021; Visser et al., 2014). Tenaga kesehatan kemudian menggabungkan nilai BPD, HC, AC, dan FL dalam suatu rumus matematis untuk memperkirakan berat janin. Formula **Hadlock** merupakan salah satu rumus yang paling banyak digunakan dalam praktik obstetri modern. Formula tersebut menghasilkan estimasi berat janin atau *estimated fetal weight* (EFW) yang kemudian dipetakan pada kurva pertumbuhan janin sesuai dengan usia gestasi (Melamed et al., 2021). Proses pemetaan ini membantu tenaga kesehatan menilai apakah pertumbuhan janin berada dalam rentang normal atau menunjukkan tanda hambatan pertumbuhan (Kingdom et al., 2023).

Tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan **USG serial** untuk memantau pertumbuhan janin secara berkala pada kehamilan dengan risiko gangguan pertumbuhan. Pemeriksaan serial biasanya dilakukan dengan interval sekitar **dua hingga empat minggu** agar perubahan pertumbuhan janin dapat diamati secara lebih akurat (Kingdom et al., 2023; Visser et al., 2014). Interval waktu tersebut memungkinkan tenaga kesehatan mengevaluasi pola pertumbuhan janin tanpa memberikan kesan perubahan ukuran yang semu akibat variasi pengukuran (Melamed et al., 2021). Tenaga kesehatan akan mempertimbangkan pemeriksaan USG serial pada beberapa kondisi klinis tertentu. Kondisi pertama meliputi hasil pengukuran TFU yang berada di bawah persentil ke-10 atau menunjukkan tren datar pada grafik pertumbuhan tinggi fundus uteri (*symphysis fundal height chart*). Temuan tersebut dapat mengindikasikan kemungkinan hambatan pertumbuhan janin sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut menggunakan USG (Kingdom et al., 2023; Melamed et al., 2021).

Tenaga kesehatan juga melakukan USG serial pada ibu hamil yang memiliki faktor risiko *fetal growth restriction*. Faktor risiko tersebut meliputi hipertensi kronik, preeklamsia, diabetes melitus, malnutrisi maternal, serta kebiasaan merokok selama kehamilan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi fungsi plasenta sehingga berpotensi mengganggu suplai oksigen dan nutrisi kepada janin (Melamed et al., 2021). Riwayat gangguan pertumbuhan janin pada kehamilan sebelumnya juga meningkatkan risiko terjadinya FGR pada kehamilan berikutnya. Tenaga kesehatan menggunakan USG serial pada kelompok ibu dengan riwayat tersebut untuk memantau pertumbuhan janin secara lebih ketat selama masa kehamilan (Kingdom et al., 2023; Visser et al.,

2014). Kehamilan kembar juga memerlukan pemantauan pertumbuhan janin yang lebih intensif melalui pemeriksaan USG serial. Pertumbuhan janin pada kehamilan multipel sering mengalami variasi yang lebih besar dibandingkan kehamilan tunggal sehingga pemantauan berkala diperlukan untuk mendeteksi kemungkinan gangguan pertumbuhan secara dini (ACOG, 2021) (Cunningham et al., 2019).

Integrasi antara pemeriksaan klinis dan pemeriksaan ultrasonografi memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai pertumbuhan janin selama masa kehamilan. Tenaga kesehatan dapat menggunakan pengukuran TFU sebagai metode skrining awal dan menggunakan USG sebagai metode konfirmasi yang lebih akurat apabila ditemukan kecurigaan gangguan pertumbuhan janin. Pendekatan terpadu ini meningkatkan ketepatan diagnosis serta membantu tenaga kesehatan menentukan strategi penatalaksanaan yang tepat bagi ibu dan janin (Kingdom et al., 2023; Melamed et al., 2021).

D. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Skenario 1 Kunjungan ANC Rutin

Seorang perempuan, usia 28 th, G2P1A0, hamil 32 minggu. ANC rutin. Ibu melaporkan bayi aktif bergerak ± 12 kali per hari. Hasil pemeriksaan: TD 112/72 mmHg. TFU 31 cm, DJJ 144 x/menit, reguler, presentasi kepala, punggung kiri.

Pertanyaan Diskusi:

1. Apakah temuan DJJ termasukan kedalam kategori normal?
2. Berdasarkan kasus di atas, apakah terdapat kesesuaian antara TFU dengan usia kehamilan?
3. Edukasi apa yang diberikan kepada ibu hingga kunjungan berikutnya?

Skenario 2 Penurunan Gerak Janin

Seorang perempuan, usia 32 th, G1P0A0, hamil 36 minggu. Keluhan bayi kurang bergerak sejak kemarin sore. Setelah diberi air manis dan berbaring 30 menit, hanya merasakan 4 gerakan. Hasil pemeriksaan: DJJ Doppler 106 x/menit, ireguler, TFU 33 cm.

Pertanyaan Diskusi:

1. Sebutkan 3 tanda bahaya pada kasus ini beserta dasar ilmiahnya!
2. Apa diagnosis yang tepat pada kasus di atas?
3. Apa tindakan yang tepat dilakukan oleh bidan?

Skenario 3 Suspect IUGR

Seorang perempuan, usia 30 th, G3P2A0, hamil 34 minggu. Riwayat hipertensi kronik. Hasil pemeriksaan: TD 148/96 mmHg, TFU hari ini 28 cm; TFU 4 minggu lalu 27 cm, DJJ 152 x/menit, regular, gerak janin aktif.

Pertanyaan Diskusi

1. Berapa hasil penghitungan TBJ menggunakan ru,us Johnson?
2. Bagaimana keterkaitan antara hipertensi dengan IUGR?
3. Pemeriksaan penunjang apa yang dibutuhkan?

TEMPLATE SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	**Komponen**	**Isi**
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Kehamilan
3	Kasus	Kehamilan fisiologis usia 32 minggu
4	Tujuan	Untuk menilai kemampuan peserta dalam melakukan asuhan kebidanan antenatal secara komprehensif
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan, usia 28 tahun, hamil 32 minggu, datang ke Puskesmas untuk ANC rutin. Ibu mengatakan bayi bergerak aktif ± 12 kali per hari. Hasil pemeriksaan: TD 112/72 mmHg, TFU 31 cm, DJJ 144 x/menit, regular, presentasi kepala, punggung kiri. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik / obstetri terfokus (leopold dan DJJ). 3. Tentukan diagnosis / masalah kebidanan. 4. Lakukan asuhan kebidanan yang sesuai.

No.	Komponen	Isi
		5. Berikan KIE kepada ibu
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan-atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: a. Actual mark (0/1/2/3) b. Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog. 2. Jika peserta melakukan pemeriksaan Leopold, berikan data: 5) TFU 31 cm 6) Presentasi kepala 7) Punggung kiri 8) Bagian terbawah belum masuk PAP 3. Jika peserta menilai DJJ: a. DJJ 144 x/menit, reguler 4. Tindakan yang diharapkan: a. Menyimpulkan kehamilan normal trimester III b. Menjelaskan kondisi ibu dan janin baik c. Memberikan edukasi - Gerakan janin

No.	Komponen	Isi
		- Tanda bahaya kehamilan - Nutrisi ibu hamil - Persiapan persalinan d. Menganjurkan kunjungan ulang INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS tampak sehat, tenang, kooperatif. 2. Tidak ada keluhan khusus. 3. Menjawab pertanyaan sesuai kondisi normal.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Tidak ada, saya mau periksa kehamilan rutin. Peserta: Bagaimana Gerakan bayi ibu? PS: Aktif, sekitar 12 kali sehari. Peserta: Ini kehamilan keberapa? PS: Kehamilan kedua. Peserta: Mari naik ke tempat tidur, saya izin melakukan pemeriksaan PS: Baik. Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.

No.	Komponen	Isi
10	Kebutuhan manikin	- Phantom abdomen hamil/manekin Leopold - Doppler / Fetoskop Pinard
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti lembar partograf/lembar instruksi bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur 2. Tensimeter 3. Stetoskop 4. Doppler 5. Meteran TFU 6. Sarung tangan 7. Handrub 8. Buku KIA 9. Pena dan catatan
13	Penulis	.....
14	Referensi	1. AWHONN. (2024). *Fetal movement monitoring and assessment guidelines.* Association of Women's Health, Obstetric and Neonatal Nurses. https://www.awhonn.org 2. Jia, Y., Ghi, T., Pereira, S., & Perez-bonfils, A. G. (2023). Pathophysiological interpretation of fetal heart rate tracings in clinical practice. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, *June*, 622–644. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pelayanan antenatal terpadu.* Kementerian Kesehatan RI. https://www.kemkes.go.id

E. DOPS

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Pemeriksaan Kehamilan Fisiologis dengan focus pada Pemeriksaan DJJ, Gerak Janin, dan Pemantauan Pertumbuhan Janin

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Pemeriksaan Kehamilan Fisiologis
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan pemeriksaan antenatal pada ibu hamil fisiologis, khususnya dalam menilai DJJ, gerak janin, dan pertumbuhan janin, serta memberikan edukasi kepada ibu.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS adalah menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan pemeriksaan kehamilan secara sistematis, aman, dan akurat, dengan fokus pada pemantauan kesejahteraan janin melalui DJJ, gerak janin, dan pertumbuhan janin.	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari pengetahuan, tetapi dari kemampuan melakukan pemeriksaan, menginterpretasikan hasil, dan memberikan edukasi yang tepat kepada ibu.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya dalam pemeriksaan ANC, identifikasi tanda bahaya, dan edukasi.	Seorang perempuan 28 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 32 minggu, datang ke puskesmas untuk pemeriksaan rutin. Ibu mengatakan janin masih aktif bergerak, tidak ada keluhan. Pemeriksaan sebelumnya normal.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Pemeriksaan Kehamilan Fisiologis
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain mengkaji Gerakan janin, menilai keadaan umum ibu, tanda vital, pemeriksaan leopold, DJJ, identifikasi tanda bahaya, edukasi.	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi ibu dan janin, menginformaikan hasil intepretasi, melakukan Tindakan yang relevan dan memberikan edukasi.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi penjelasan informed consent, persiapan alat, Teknik pemeriksaan DJJ, anamnesis Gerak janin, pengukuran TFU, intpretasi hasilm komunikasi dan edukasi, serta profesionalisme.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan tindakan dengan memperhatikan teknik, komunikasi, dan intepretasi. Contohnya: gerak janin dinilai dengan anamnesis terstruktur, DJJ dihitung dengan benar dan akurat, TFU diukur dengan teknik yang tepat, mahasiswa menyimpulkan kehamilan fisiologis.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah ketepatan Teknik pemeriksaan, urutan pemeriksaan yang sistematis, ketelitian dalam intepretasi, kemampuan edukasi kepada pasien.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menjelaskan bahwa DJJ normal, gerak janin baik, dan pertumbuhan sesuai usia kehamilan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Pemeriksaan Kehamilan Fisiologis
	sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	melakukan pemeriksaan DJJ dan komunikasi, namun perlu meningkatkan ketelitian dalam pengukuran TFU dan memperjelas edukasi gerak janin.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali kegawatan, salah menentukan prioritas, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus partus lama dan distosia, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan tindakan awal kegawatdaruratan persalinan secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

F. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Pemeriksaan Kehamilan Fisiologis dengan focus pada Pemeriksaan DJJ, Gerak Janin, dan Pemantauan Pertumbuhan Janin

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pemeriksaan Kehamilan Fisiologis
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada kasus ini, portofolio menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan pemeriksaan DJJ, gerak janin, dan pertumbuhan janin secara konsisten.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan perkembangan kemampuan mahasiswa dalam pemeriksaan kehamilan.	Mahasiswa menunjukkan peningkatan dalam Teknik pemeriksaan, intepretasi hasil, dan edukasi pasien.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan pemeriksaan DJJ, TFU, dan edukasi. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan praktik langsung pada pasien ANC.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pemeriksaan Kehamilan Fisiologis
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus ibu G2P1A0 usia kehamilan 32 minggu, DJJ normal (120-160 x/menit), gerak janin aktif, TFU sesuai usia kehamilan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya ketelitian pemeriksaan DJJ, pemantauan Gerak janin, deteksi dini gangguan pertumbuhan.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan pemeriksaan, tetapi perlu meningkatkan konsistensi teknik dan dokumentasi.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menilai dan intepretasi pasien dan melakukan tindakan secara aman.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pemeriksaan Kehamilan Fisiologis
		melakukan pemeriksaan ANC, intepretasi normal, dan edukasi ibu.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik pemeriksaan kehamilan fisiologis, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel. Case Report pada Pemeriksaan Kehamilan Fisiologis dengan focus pada Pemeriksaan DJJ, Gerak Janin, dan Pemantauan Pertumbuhan Janin

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pemeriksaan Kehamilan Fisiologis
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya dengan hasil pemeriksaan fisiologis.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan awal yang diberikan, rencana

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pemeriksaan Kehamilan Fisiologis
		tindakan berikutnya, dan kunjungan ulang.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan data lengkap pasien, seperti usia kehamilan, keluhan, gerak janin, DJJ, hasil pemeriksaan leopold, intepretasi, edukasi, dan tindakan yang diberikan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan tindakan berdasarkan ketepatan data, analisis, dan hasil akhir.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus mahasiswa dapat membedakan kasus kehamilan fisiologis dan patologis.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep partus lama dan distosia, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Pemeriksaan Kehamilan Fisiologis dengan focus pada Pemeriksaan DJJ, Gerak Janin, dan Pemantauan Pertumbuhan Janin

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pemeriksaan Kehamilan Fisiologis
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada pemeriksaan ANC, mahasiswa merefleksikan bahwa meskipun kehamilan tampak normal, kegagalan melakukan pemeriksaan dasar seperti DJJ, gerak janin, dan TFU dapat menyebabkan keterlambatan deteksi kondisi berbahaya pada janin.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa pemeriksaan sederhana seperti menghitung DJJ dan menanyakan gerak janin memiliki peran besar dalam mencegah kejadian gawat janin.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah risiko jika DJJ tidak diperiksa dengan benar, risiko kurangnya edukasi gerak janin, risiko keterlambatan deteksi gangguan pertumbuhan.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain gawat janin yang tidak terdeteksi, ibu tidak menyadari penurunan gerak janin, pertumbuhan janin tidak sesuai.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat	Mahasiswa menuliskan pentingnya tindakan pencegahan yaitu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pemeriksaan Kehamilan Fisiologis
	dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	pemeriksaan rutin DJJ, edukasi kick chart, pengukuran TFU berkala.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa memahami bahwa pemeriksaan sederhana sangat penting, edukasi ibu berperan besar dalam deteksi dini.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap 109 rofessional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

G. Tabel Red Flags & Eskalasi

Penilaian Kesejahteraan Janin: DJJ, Gerak Janin, dan Pemantauan Pertumbuhan

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
DJJ < 110 dpm (bradikardia)	Hipoksia janin / gangguan oksigenasi	- Posisi ibu miring kiri - Evaluasi ulang DJJ - Berikan oksigen - Segera rujuk
DJJ > 160 dpm (takikardia persisten)	Infeksi, distress janin, hipoksia	- Evaluasi kondisi ibu (demam, dehidrasi) - Observasi ulang DJJ - Rujuk jika persisten
DJJ tidak terdengar	Kemungkinan IUFD / kesalahan teknik	- Ulangi pemeriksaan (pastikan teknik benar) - Gunakan alat lain (Doppler) - Rujuk untuk USG
Late deceleration	Insufisiensi utero-plasenta (patologis)	- Miring kiri - Hentikan oksitosin (jika ada)

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
		- Berikan oksigen - Rujuk segera
DJJ tidak teratur	Aritmia janin	- Observasi ulang - Rujuk untuk evaluasi lanjutan
Gerak janin < 10 kali/12 jam	Decreased fetal movement (DFM)	- Evaluasi segera - Anjurkan ibu observasi ulang - Rujuk jika menetap
Penurunan gerak janin secara tiba-tiba	Tanda awal distress janin	- Lakukan pemeriksaan DJJ - Edukasi segera - Rujuk
Tidak ada gerak janin	Kegawatan serius / kemungkinan IUFD	- Konfirmasi dengan DJJ - Rujuk segera
Ibu tidak memahami pemantauan gerak janin	Risiko keterlambatan deteksi	- Edukasi kick count - Jelaskan tanda bahaya
Pola gerak berubah	Gangguan kesejahteraan janin	- Observasi - Evaluasi DJJ dan TFU - Rujuk bila perlu
TFU tidak sesuai usia kehamilan	Gangguan pertumbuhan janin	- Evaluasi ulang - Bandingkan dengan data sebelumnya - Rujuk
TFU tidak meningkat (plateau 2 kali kunjungan)	Fetal Growth Restriction (FGR)	- Rujuk untuk USG biometri
TFU terlalu kecil	IUGR / Oligohidramnion	- Rujuk
TFU terlalu besar	Makrosomia / polihidramnion	- Evaluasi lanjut - Rujuk
Tidak dilakukan pengukuran TFU	Tidak terdeteksi gangguan pertumbuhan	- Lakukan pengukuran rutin setiap ANC

H. Rangkuman Materi

Pemantauan kesejahteraan janin dalam kehamilan fisiologis merupakan bagian penting dari pelayanan antenatal yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini adanya gangguan pada janin. Salah satu indikator utama adalah denyut jantung janin (DJJ). DJJ normal berada pada rentang 110–160 denyut per menit sesuai standar FIGO. Kondisi di luar rentang ini, seperti bradikardia (<110 dpm) maupun takikardia (>160 dpm) yang terjadi secara persisten, merupakan tanda bahaya (*red flags*) yang memerlukan evaluasi segera karena dapat mengindikasikan adanya gangguan pada janin. Selain itu, pola DJJ juga perlu diperhatikan, terutama adanya *late deceleration* yang selalu bersifat patologis karena mencerminkan insufisiensi utero-plasenta. Kondisi ini memerlukan tindakan cepat seperti memposisikan ibu miring ke kiri, menghentikan pemberian oksitosin jika ada, memberikan oksigen, serta segera melakukan rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap.

Selain DJJ, gerak janin menjadi indikator subjektif yang sangat penting dalam menilai kesejahteraan janin. Metode yang umum digunakan adalah metode Cardiff, di mana janin diharapkan bergerak minimal 10 kali dalam 12 jam. Penurunan gerak janin (*decreased fetal movement* atau DFM) tidak boleh diabaikan karena terbukti meningkatkan risiko *stillbirth* secara signifikan. Oleh karena itu, ibu hamil perlu diedukasi untuk secara aktif memantau gerakan janinnya setiap hari, sehingga perubahan pola gerakan dapat segera dikenali dan dilaporkan kepada tenaga kesehatan.

Pemantauan pertumbuhan janin juga dilakukan melalui pengukuran tinggi fundus uteri (TFU). Secara umum, setelah usia kehamilan 20 minggu, nilai TFU dalam sentimeter kurang lebih sama dengan usia kehamilan dalam minggu dengan toleransi ±2 cm. Apabila ditemukan TFU yang tidak mengalami peningkatan atau cenderung menetap (plateau) dalam dua kali kunjungan berturut-turut, hal ini merupakan tanda bahaya yang mengarah pada kemungkinan *fetal growth restriction* (FGR) dan memerlukan rujukan untuk pemeriksaan lanjutan seperti USG biometri. Penilaian kesejahteraan janin akan menjadi lebih akurat apabila dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan menggabungkan hasil pemeriksaan DJJ, gerak janin, dan TFU. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan jika hanya menggunakan satu parameter saja. Dalam praktiknya, kombinasi ketiga aspek ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk mendeteksi lebih dini adanya penyimpangan dari kondisi normal dan mengambil tindakan yang tepat.

Selain pemeriksaan klinis, edukasi kepada ibu hamil merupakan komponen yang tidak kalah penting. Edukasi mengenai cara menghitung gerak janin (*kick*

count) serta pengenalan tanda bahaya seperti penurunan gerakan janin merupakan intervensi yang sederhana, berbiaya rendah, namun memiliki dampak yang sangat besar dalam mencegah keterlambatan penanganan. Dengan pemahaman yang baik, ibu dapat berperan aktif dalam memantau kondisi janinnya dan segera mencari pertolongan jika terjadi perubahan yang mencurigakan.

Dengan demikian, pemantauan DJJ, gerak janin, dan pertumbuhan janin melalui TFU, serta edukasi yang adekuat kepada ibu, merupakan pilar utama dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan janin selama kehamilan.

I. Daftar Pustaka

ACOG. (2021). *Practice Bulletin No. 227: Fetal growth restriction*.

AWHONN. (2024). *Fetal movement monitoring and assessment guidelines* (O. and N. N. Association of Women's Health (ed.)). https://www.awhonn.org

Bradford, B. F., Cronin, R. S., Okesene-gafa, K. A., Apaapa-timu, T. H. S., Shashikumar, A., & Oyston, C. J. (2024). Diabetes in pregnancy : Women ' s views of care in a multi-ethnic , low socioeconomic population with midwifery continuity-of-care. *Women and Birth*, *37*(3), 101579. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2024.01.005

Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Sheffield, J. S. (2019). *Williams obstetrics (26th ed.)* (T. W. Sadler (ed.)). McGraw-Hill Education.

Ego, A., Monier, I., Vilotitch, A., Kayem, G., Vayssiere, C., Verspyck, E., & Zeitlin, J. (2023). Serial plotting of symphysis – fundal height and estimated fetal weight to improve the antenatal detection of infants small for gestational age : A cluster randomised trial. *BJOG An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, *130*(February), 729–739. https://doi.org/10.1111/1471-0528.17399

Gordijn, S. J., Beune, I. M., & Wynia, K. (2016). Consensus definition of fetal growth restriction : a Delphi procedure. *Ultrasound Obstet Gynecol*, *48*(February), 333–339. https://doi.org/10.1002/uog.15884

Hall, J. E., & Hall, M. E. (2020). *Guyton and Hall textbook of medical physiology (14th ed.)*. Elsevier.

Hayes, D. J. L., Dumville, J. C., Walsh, T., Higgins, L. E., Fisher, M., Akselsson, A., Whitworth, M., & Heazell, A. E. P. (2023). Systematic Review Effect of encouraging awareness of reduced fetal movement and subsequent clinical management on pregnancy outcome : a systematic review and meta-analysis. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, *March*. https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2022.100821

Heney, J. O., Mcallister, S., Maresh, M., & Blott, M. (2022). Fetal monitoring in

labour : summary and update of NICE guidance. *The BMJ*, *379*, 1–4. https://doi.org/10.1136/bmj.o2854

Jia, Y., Ghi, T., Pereira, S., & Perez-bonfils, A. G. (2023). Pathophysiological interpretation of fetal heart rate tracings in clinical practice. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, *June*, 622–644.

Kemenkes RI. (2020). *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu* (3rd ed.). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kingdom, J., Ashwal, E., Lausman, A. C. N., Bujold, E., & Melamed, N. (2023). Guideline No. 442: Fetal Growth Restriction: Screening, Diagnosis, and Management in Singleton Pregnancies. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*, *45*(10). https://doi.org/10.1016/j.jogc.2023.05.022

Lowdermilk, D. L., Cashion, K., Perry, S. E., Alden, K. R., & Olshansky, E. (2019). *Maternity and Women's Health Care*. Elsevier.

Melamed, N., Hiersch, L., Aviram, A., Mei-dan, E., & Keating, S. (2021). Diagnostic accuracy of fetal growth charts for placenta-related fetal growth restriction. *Placenta*, *105*(October 2020), 70–77. https://doi.org/10.1016/j.placenta.2021.01.022

Moore, K. L., Persaud, T. V. N., & Torchia, M. G. (2020). *The developing human: Clinically oriented embryology (11th ed.)*. Elsevier.

Papageorghiou, A. T., Ohuma, E. O., Gravett, M. G., Hirst, J., Silveira, M. F., Lambert, A., Carvalho, M., Jaffer, Y. A., Altman, D. G., Noble, J. A., Bertino, E., Purwar, M., Pang, R., Ismail, L. C., Victora, C., Bhutta, Z. A., Kennedy, S. H., Villar, J., Fetal, I., & Growth, N. (2016). International standards for symphysis-fundal height based on serial measurements from the Fetal Growth Longitudinal Study of the INTERGROWTH-21st Project : prospective cohort study in eight countries. *BMJ Open Access*, 1–7. https://doi.org/10.1136/bmj.i5662

Pavithra, K., Priyadarshini, K., & Annapoorna, Y. (2022). Estimation of fetal weight by clinical method and its comparison with ultrasonography and its correlation with actual birth weight in term singleton pregnancy. *Indian Journal of Obstetrics and Gynecology Research*, *9*(3), 347–351.

Sehrawat, K., & Panchanadikar, T. M. (2020). Johnson ' s formula to compare fetal weight with actual birth weight. *Indian Journal of Obstetrics and Gynecology Research*, *7*(2), 147–152.

Thompson, J. M. D., Wilson, J., Bradford, B. F., Li, M., Cronin, R. S., Gordon, A., Raynes-greenow, C. H., Stacey, T., Cullling, V. M., Askie, L. M., Brien, L. M. O., Mitchell, E. A., Mccowan, L. M. E., & Heazell, A. E. P. (2021). A better understanding of the association between maternal perception of foetal movements and late stillbirth — findings from an individual participant data meta- analysis. *BMC Medicine*, *19*(267), 2–12.

Tsakiridis, I., Zerva, C., Mamopoulos, A., Kalogiannidis, I., Athanasiadis, A., & Dagklis, T. (2022). Maternal perception of fetal movements : onset and associated factors. *Jpurnal Perinatal Med*, *50*(9), 1174–1179.

Visser, G. H. A., Figueras, F., & Gratacós, E. (2014). Fetal Growth Restriction Nutritional Care of Preterm Infants. *Fetal Diagn Ther*, *36*(2).

WHO. (2016). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*.

WHO. (2022). *WHO recommendations on intrapartum fetal monitoring*.

PROFIL PENULIS



Dr. Bd. Ika Nur Saputri, SST., M.Keb. Lahir di Bah Butong pada 18 Agustus 1987.. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Bidan Pendidik (D4) Universitas Sumatera Utara tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Brawijaya Malang dan lulus tahun pada tahun 2014. Pada tahun 2025 penulis menyelesaikan pendidikan Program Doktor Kesehatan Masyarakat di Universitas Andalas Padang. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 di Akademi Kebidanan Medistra Lubuk Pakam. Saat ini penulis bekerja di Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam mengampu mata kuliah yang berfokus pada kebidanan dan kesehatan reproduksi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan pembicara dalam berbagai kegiatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ikanursaputri@medistra.ac.id

Motto: "Syukur menjadikan hati tenang, sabar menjadikan langkah kuat"



Feby Purnamasari, S.ST., Bdn., M.Keb. Ketua Prodi kebidanan STIKes Salewangang Maros. Alamat: Jl Goa Ria Permai blok B/1 Sudiang Makassar. TTL: Siri Sori Alamatu / 26 feb 1994. Lahir di ambon dan besar di pangkep skrg tinggal sudiang makassar. D3 : STIKes Salewangang Maros 2011. D4/S1: Universitas Mega Rezky Makassar 2016. S2 : Universitas Hasanuddin 2019. Kontak: 082189311228. Penulis beberapa buku saku kebidanan dan eboocharpter berISBN sebanyak 7 eks dan 2 buku daftar tilik lingkungan stikes. Merupakan editor dan reviewer beberapa jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat. Pemilik jurnal sarana riset ilmiah. Keanggotaan IBI Maros. Rekognisi dosen diantara sebagai aktif penulis buku, jurnal dan juga menjuara beberapa oral presentasi kebidanan. Serta berhasil mendapat hibah penelitian dosen kemdiksaintek 2021 dan hibah pengabdian masyarakat dosen kemdiksaintek 2026 dan hibah publikasi kemdiksaintek di tahun 2025. Email: febypurnamasari934@gmail.com

PROFIL PENULIS



Frani Mariana, SST., M.Keb. Penulis Lahir di Sebapo, 22 September 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kebidanan di Stikes Aisyiyah Yogyakarta dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Aisyiyah Yogyakarta dan lulus pada tahun 2019. Saat ini penulis bekerja di Universitas Sari Mulia mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan, Anatomi dan Fisiologi Manusia, Psikologi dalam Praktik Kebidanan, Kebijakan Publik dalam Pelayanan Kebidanan dan Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar yang berfokus pada tema kesehatan ibu dan anak. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: franimariana88@gmail.com.



Sunaeni,S.St.,M.Keb. Lahir di Malang, 12 September 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi D4 Kebidanan STIKes Insan Unggul Surabayam, lulus Tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Pdjadjaran Bandung dan lulus tahun pada tahun 2010. Riwayat pekerjaan sebagai dosen di Poltekkes Kemnkes Sorong tahun 2013-2023. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemnkes Malang mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Persalinan, Nifas, Manajemen Asuhan Kebidanan Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sunaeni@poltekkes-malang.ac.id

PROFIL PENULIS



Ekki Noviana, M.Tr.Keb., Bd. Lahir di Brebes, 29 November 1996. Penulis menyelesaikan studi Diploma IV Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Semarang (2014), Profesi Bidan di Poltekkes Kemenkes Semarang (2018), dan Pasca Sarjana Kebidanan Terapan di Poltekkes Kemenkes Semarang (2019).

Penulis aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan seperti seminar, workshop, dan pelatihan. Selain itu penulis juga menjabat sebagai dosen tetap prodi D III Kebidanan di Universitas Ummi Bogor sejak tahun 2022-sekarang. Penulis mengampu mata kuliah Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan, Asuhan Kebidanan Persalinan, Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui. Email aktif: ekkinoviana4@gmail.com

Motto: "perbedaan orang yang sukses dengan yang tidak/belum sukses bukan terletak pada kemampuannya, tapi pada kemauannya"

Sinopsis

Buku Ajar Pemeriksaan Antenatal Terpadu: Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, dan Interpretasi Temuan merupakan buku ajar yang membahas pemeriksaan antenatal secara sistematis, komprehensif, dan sesuai dengan standar pelayanan ANC. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa kebidanan memahami konsep dasar pemeriksaan antenatal terpadu, tujuan pemeriksaan, sasaran dan indikator pelayanan antenatal care, serta standar praktik yang mencakup jadwal kunjungan, komponen minimal pemeriksaan, dan indikator mutu pelayanan. Melalui pembahasan ini, pembaca diarahkan untuk memahami pentingnya pemeriksaan antenatal sebagai upaya pemantauan kesehatan ibu dan janin, deteksi dini risiko, serta dasar dalam menentukan tindak lanjut asuhan kebidanan.

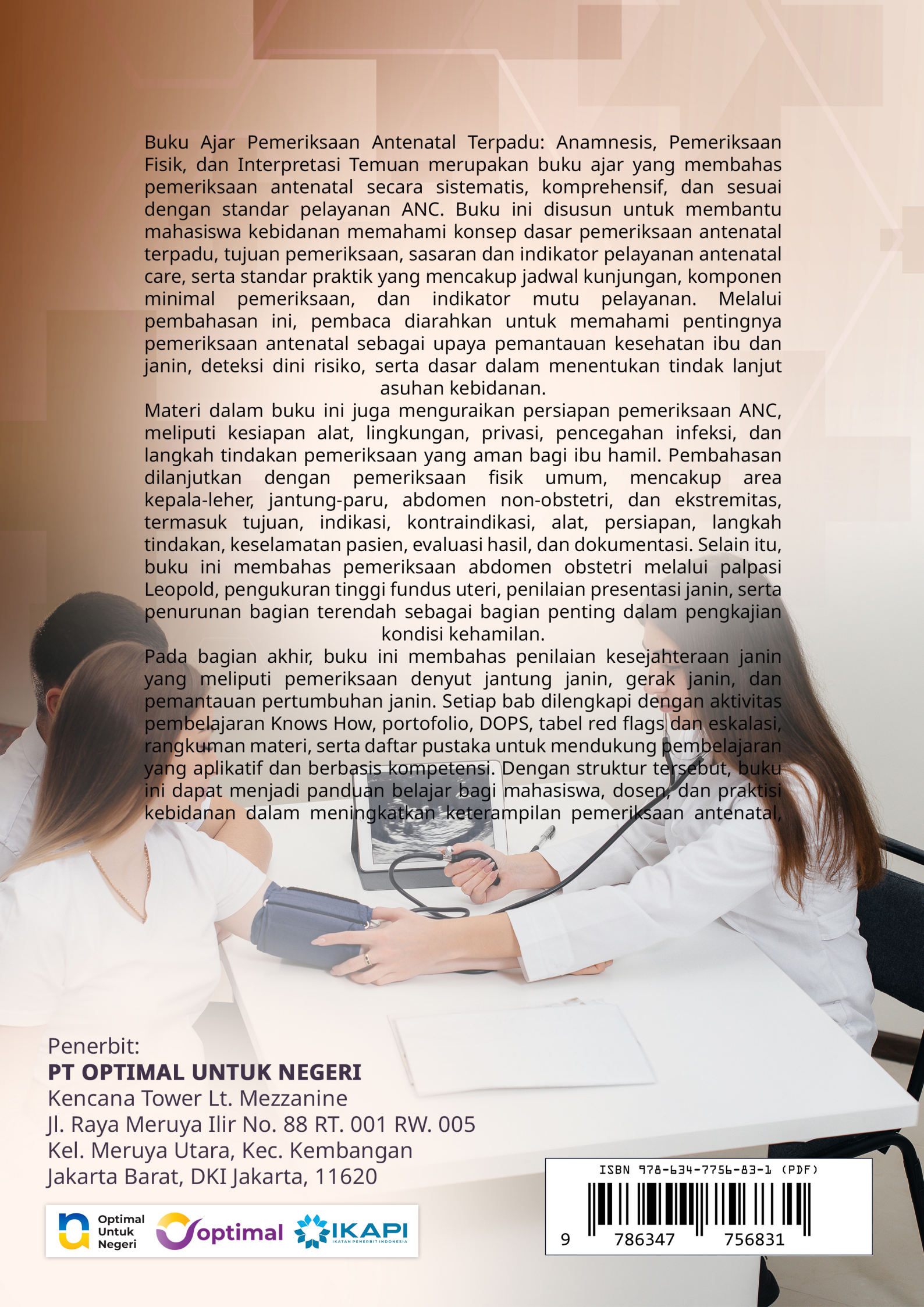
Materi dalam buku ini juga menguraikan persiapan pemeriksaan ANC, meliputi kesiapan alat, lingkungan, privasi, pencegahan infeksi, dan langkah tindakan pemeriksaan yang aman bagi ibu hamil. Pembahasan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik umum, mencakup area kepala-leher, jantung-paru, abdomen non-obstetri, dan ekstremitas, termasuk tujuan, indikasi, kontraindikasi, alat, persiapan, langkah tindakan, keselamatan pasien, evaluasi hasil, dan dokumentasi. Selain itu, buku ini membahas pemeriksaan abdomen obstetri melalui palpasi Leopold, pengukuran tinggi fundus uteri, penilaian presentasi janin, serta penurunan bagian terendah sebagai bagian penting dalam pengkajian kondisi kehamilan.

Pada bagian akhir, buku ini membahas penilaian kesejahteraan janin yang meliputi pemeriksaan denyut jantung janin, gerak janin, dan pemantauan pertumbuhan janin. Setiap bab dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran *Knows How*, portofolio, DOPS, tabel *red flags* dan eskalasi, rangkuman materi, serta daftar pustaka untuk mendukung pembelajaran yang aplikatif dan berbasis kompetensi. Dengan struktur tersebut, buku ini dapat menjadi panduan belajar bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi kebidanan dalam meningkatkan keterampilan pemeriksaan antenatal, kemampuan interpretasi temuan, serta kesiapan mengambil keputusan klinis yang aman dan tepat bagi ibu serta janin.

Buku Ajar Pemeriksaan Antenatal Terpadu: Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, dan Interpretasi Temuan merupakan buku ajar yang membahas pemeriksaan antenatal secara sistematis, komprehensif, dan sesuai dengan standar pelayanan ANC. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa kebidanan memahami konsep dasar pemeriksaan antenatal terpadu, tujuan pemeriksaan, sasaran dan indikator pelayanan antenatal care, serta standar praktik yang mencakup jadwal kunjungan, komponen minimal pemeriksaan, dan indikator mutu pelayanan. Melalui pembahasan ini, pembaca diarahkan untuk memahami pentingnya pemeriksaan antenatal sebagai upaya pemantauan kesehatan ibu dan janin, deteksi dini risiko, serta dasar dalam menentukan tindak lanjut asuhan kebidanan.

Materi dalam buku ini juga menguraikan persiapan pemeriksaan ANC, meliputi kesiapan alat, lingkungan, privasi, pencegahan infeksi, dan langkah tindakan pemeriksaan yang aman bagi ibu hamil. Pembahasan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik umum, mencakup area kepala-leher, jantung-paru, abdomen non-obstetri, dan ekstremitas, termasuk tujuan, indikasi, kontraindikasi, alat, persiapan, langkah tindakan, keselamatan pasien, evaluasi hasil, dan dokumentasi. Selain itu, buku ini membahas pemeriksaan abdomen obstetri melalui palpasi Leopold, pengukuran tinggi fundus uteri, penilaian presentasi janin, serta penurunan bagian terendah sebagai bagian penting dalam pengkajian kondisi kehamilan.

Pada bagian akhir, buku ini membahas penilaian kesejahteraan janin yang meliputi pemeriksaan denyut jantung janin, gerak janin, dan pemantauan pertumbuhan janin. Setiap bab dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran Knows How, portofolio, DOPS, tabel red flags dan eskalasi, rangkuman materi, serta daftar pustaka untuk mendukung pembelajaran yang aplikatif dan berbasis kompetensi. Dengan struktur tersebut, buku ini dapat menjadi panduan belajar bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi kebidanan dalam meningkatkan keterampilan pemeriksaan antenatal,



Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-83-1 (PDF)
9 786347 756831